ACADEMIA EXAMEN EUNACOM

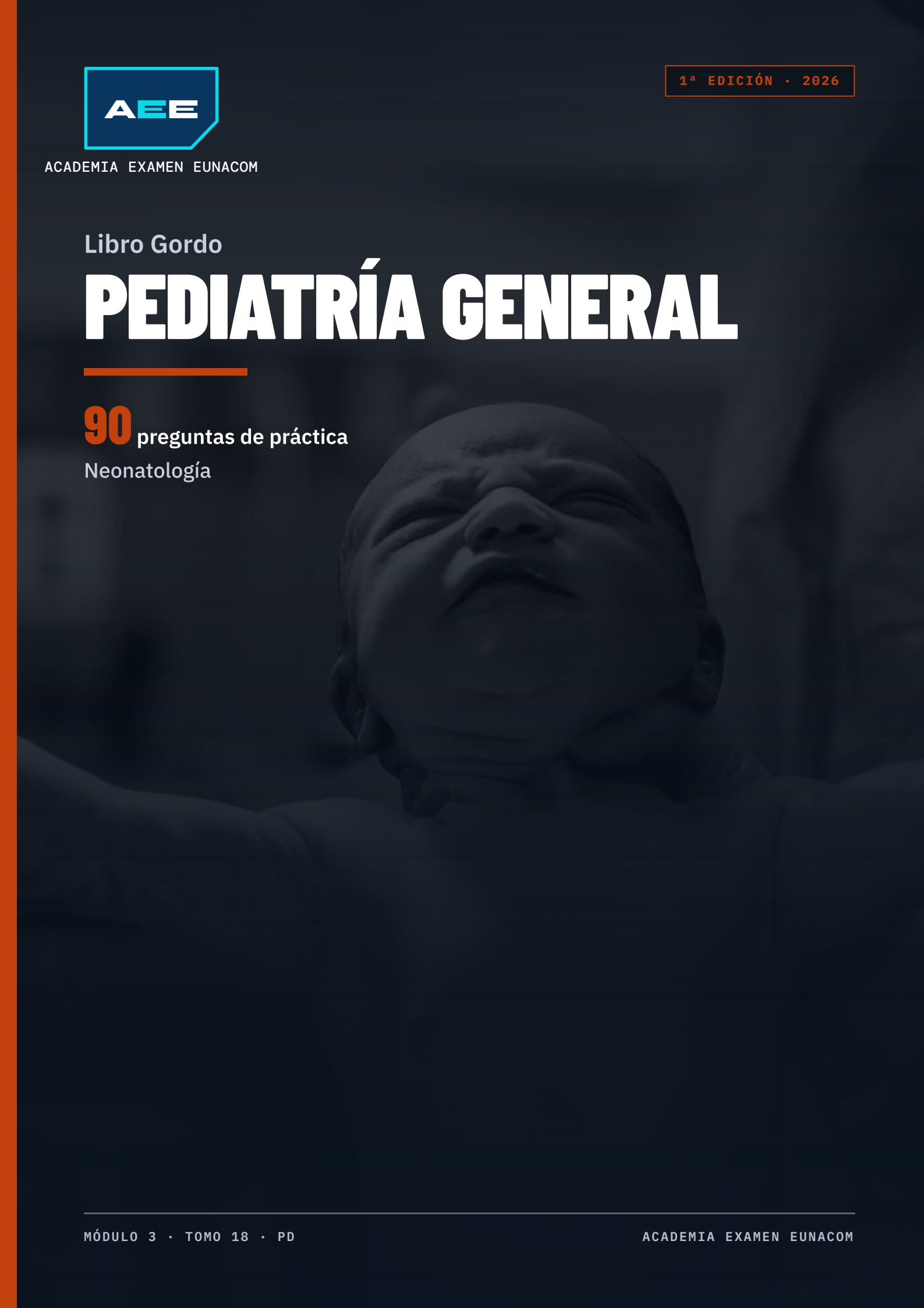
1ª EDICIÓN · 2026

Libro Gordo

PEDIATRÍA GENERAL

90 preguntas de práctica

Neonatología



MATRIZ PERFIL V3 · DISTRIBUCIÓN POR BLOQUES

Pediatría General · Secuencia Cardinal de Estudio (Bloque 1 a 5)

TOMO 18 · PARTE A: POR BLOQUES

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA	NIVEL LEGAL EXIGIDO	GES	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
BLOQUE 1: CRECIMIENTO, DESARROLLO & VACUNAS PNI					
2.01.1.020	Bronquiolitis Aguda & Síndrome Bronquial Obstructivo (SBO): VRS, Score de Tal y Manejo Escalonado	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	GES	Q12	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.032	Leucemias	Dx: **Sospecha** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar**	—	Q1	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.035	Bronquiolitis Aguda & Síndrome Bronquial Obstructivo (SBO): VRS, Score de Tal y Manejo Escalonado	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q13	Tomo 18 · C.13 (Pág. 30)
2.01.1.037	Tumores sólidos	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q2	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.048	Bronquiolitis Aguda & Síndrome Bronquial Obstructivo (SBO): VRS, Score de Tal y Manejo Escalonado	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q14	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.050	Cardiopatías congénitas frecuentes	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q3	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.072	Evaluación del Crecimiento & Estado Nutricional en Pediatría: Curvas OMS (P/E, T/E, P/T)	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar**	GES	Q8	Tomo 18 · C.7 (Pág. 18)
2.01.1.083	Desarrollo Psicomotor: Hitos Madurativos & Baterías de Tamizaje (EEDP y TEPSI)	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q10	Tomo 18 · 18.2 (Pág. 7)
2.01.1.095	Bronquiolitis Aguda & Síndrome Bronquial Obstructivo (SBO): VRS, Score de Tal y Manejo Escalonado	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q15	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.141	Evaluación del Crecimiento & Estado Nutricional en Pediatría: Curvas OMS (P/E, T/E, P/T)	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q9	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.2.001	Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI Chile): Calendario de Vacunación Obligatorio 2026	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q11	Tomo 18 · 18.3 (Pág. 9)
2.01.2.005	Bronquiolitis Aguda & Síndrome Bronquial Obstructivo (SBO): VRS, Score de Tal y Manejo Escalonado	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar**	GES	Q16	Tomo 18 · C.6 (Pág. 16)
2.01.2.010	Hemorragia digestiva	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q4	Tomo 18 · C.1 (Pág. 6)
2.01.2.013	Bronquiolitis Aguda & Síndrome Bronquial Obstructivo (SBO): VRS, Score de Tal y Manejo Escalonado	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q17	Tomo 18 · C.4 (Pág. 12)
2.01.2.016	Meningococcemia	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q5	Tomo 18 · C.21 (Pág. 46)
2.01.2.023	Shock	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q6	Tomo 18 · C.29 (Pág. 62)

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA	NIVEL LEGAL EXIGIDO	GES	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
2.01.2.024	Bronquiolitis Aguda & Síndrome Bronquial Obstructivo (SBO): VRS, Score de Tal y Manejo Escalonado	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q18	Tomo 18 · C.30 (Pág. 64)
2.01.2.144	SARS Cov 2 COVID 19	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	—	Q7	Tomo 02 · 5.6 (Pág. 65)
BLOQUE 2: RESPIRATORIO PEDIÁTRICO & URGENCIAS					
2.01.1.009	Síndrome Febril Agudo sin Foco en el Lactante: Estratificación según Edad, Criterios de Rochester y Manejo	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	GES	Q32	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.011	Síndrome Febril Agudo sin Foco en el Lactante: Estratificación según Edad, Criterios de Rochester y Manejo	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q33	Tomo 18 · C.9 (Pág. 22)
2.01.1.015	Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC) Pediátrica: Diagnóstico, Amoxicilina vs Ampicilina y Criterios de Hospitalización	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q27	Tomo 18 · 18.7 (Pág. 28)
2.01.1.024	Síndrome Febril Agudo sin Foco en el Lactante: Estratificación según Edad, Criterios de Rochester y Manejo	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q34	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.027	Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC) Pediátrica: Diagnóstico, Amoxicilina vs Ampicilina y Criterios de Hospitalización	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q28	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.038	Constipación	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	—	Q19	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.062	Síndrome Febril Agudo sin Foco en el Lactante: Estratificación según Edad, Criterios de Rochester y Manejo	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q35	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.076	Talla baja	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q20	Tomo 18 · C.11 (Pág. 26)
2.01.1.111	Malformaciones vasculares cutáneas	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q21	Tomo 16 · 16.17 (Pág. 56)
2.01.2.002	Laringitis Aguda Obstructiva / Croup: Score de Taussig, Adrenalina Racémica y Dexametasona	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q26	Tomo 18 · 18.6 (Pág. 24)
2.01.2.003	Cuerpo Extraño en Vía Aérea: Maniobras de Desobstrucción según Edad & Broncoscopía	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q29	Tomo 18 · 18.8 (Pág. 32)
2.01.2.004	Compromiso de conciencia	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q22	Tomo 18 · C.5 (Pág. 14)
2.01.2.011	Hipertensión endocraneana	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q23	Tomo 18 · C.2 (Pág. 8)
2.01.2.017	Muerte súbita-ALTE, BRUE	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q24	Tomo 18 · C.13 (Pág. 30)
2.01.2.018	Cuerpo Extraño en Vía Aérea: Maniobras de Desobstrucción según Edad & Broncoscopía	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar**	—	Q30	Tomo 18 · C.14 (Pág. 32)
2.01.2.019	Cuerpo Extraño en Vía Aérea: Maniobras de Desobstrucción según Edad & Broncoscopía	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q31	Tomo 18 · C.25 (Pág. 54)

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA	NIVEL LEGAL EXIGIDO	GES	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
2.01.2.025	Síndrome Febril Agudo sin Foco en el Lactante: Estratificación según Edad, Criterios de Rochester y Manejo	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q36	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.2.026	Traumatismo encéfalo- craneano	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q25	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
BLOQUE 3: INFECCIONES, EXANTEMAS & DIGESTIVO PEDIÁTRICO					
2.01.1.007	Enteroparasitosis	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	—	Q37	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.008	Exantemas Infantiles: Diagnóstico Diferencial (Eritema Infeccioso, Exantema Súbito, Escarlatina, Varicela y Kawasaki)	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	GES	Q47	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.023	Faringoamigdalitis	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	—	Q38	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.025	Laringitis Aguda Obstructiva / Croup: Score de Taussig, Adrenalina Racémica y Dexametasona	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q54	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.029	Sinusitis	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	—	Q39	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.039	Diarrea Aguda Infantil y Planes de Rehidratación Oral OMS (Plan A, B, C) y Síndrome Hemolítico Urémico	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	GES	Q49	Tomo 18 · 18.11 (Pág. 51)
2.01.1.046	Vómitos en el Lactante: RGE Fisiológico vs Estenosis Hipertrófica del Píloro (EHP) vs Invaginación Intestinal	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q51	Tomo 18 · 18.12 (Pág. 55)
2.01.1.054	Soplos	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q40	Tomo 18 · 18.23 (Pág. 34)
2.01.1.058	Exantemas Infantiles: Diagnóstico Diferencial (Eritema Infeccioso, Exantema Súbito, Escarlatina, Varicela y Kawasaki)	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q48	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.067	Diarrea Aguda Infantil y Planes de Rehidratación Oral OMS (Plan A, B, C) y Síndrome Hemolítico Urémico	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q50	Tomo 18 · C.4 (Pág. 12)
2.01.1.073	Diabetes	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q41	Tomo 18 · C.8 (Pág. 20)
2.01.1.074	Hiperplasia suprarrenal congénita	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q42	Tomo 18 · C.9 (Pág. 22)
2.01.1.081	Bronquiolitis Aguda & Síndrome Bronquial Obstructivo (SBO): VRS, Score de Tal y Manejo Escalonado	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	GES	Q53	Tomo 18 · C.16 (Pág. 36)
2.01.1.108	Dermatitis del pañal y de contacto	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	—	Q43	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.2.006	Convulsiones Febriles: Crisis Simple vs Compleja, Punción Lumbar & Pronóstico	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q52	Tomo 18 · 18.14 (Pág. 59)
2.01.2.007	Emergencia hipertensiva	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar**	—	Q44	Tomo 18 · C.9 (Pág. 22)

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA	NIVEL LEGAL EXIGIDO	GES	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
2.01.2.012	Insuficiencia cardíaca. Edema pulmonar	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar**	—	Q45	Tomo 18 · 18.23 (Pág. 34)
2.01.2.020	Paro cardiorrespiratorio	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar**	—	Q46	Tomo 18 · 18.24 (Pág. 36)
BLOQUE 4: NEONATOLOGÍA & SALA DE PARTOS					
2.01.1.010	Hepatitis viral	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	—	Q55	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.013	Síndrome Febril Agudo sin Foco en el Lactante: Estratificación según Edad, Criterios de Rochester y Manejo	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q71	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.018	Exantemas Infantiles: Diagnóstico Diferencial (Eritema Infeccioso, Exantema Súbito, Escarlatina, Varicela y Kawasaki)	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q67	Tomo 18 · 18.10 (Pág. 47)
2.01.1.026	Atención Inmediata del Recién Nacido & Reanimación Neonatal: Algoritmo AAP/AHA, Minuto de Oro y Test de APGAR	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	GES	Q68	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.030	Adenopatías	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar**	—	Q56	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.043	Hemorragia digestiva	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar**	—	Q57	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.055	Alergias	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	—	Q58	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.056	Inmunodeficiencias	Dx: **Sospecha** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar**	—	Q59	Tomo 18 · 18.25 (Pág. 61)
2.01.1.057	Mesenquimopatías	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q60	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.093	Síndrome Febril Agudo sin Foco en el Lactante: Estratificación según Edad, Criterios de Rochester y Manejo	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q72	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.116	Enterocolitis necrotizante (ECN)	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q61	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.121	Ictericia Neonatal: Fisiológica vs Patológica (< 24 h), Incompatibilidad ABO/Rh, Curvas Bhutani y Fototerapia	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q70	Tomo 18 · 18.17 (Pág. 74)
2.01.1.127	TORCH	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q62	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.128	Evaluación de la Edad Gestacional (Capurro/Ballard) & Clasificación Ponderal Neonatal	Dx: **Sospecha** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar**	GES	Q69	Tomo 18 · 18.16 (Pág. 72)
2.01.1.133	Malformaciones congénitas más frecuentes	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q63	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.2.008	Epistaxis	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	—	Q64	Tomo 18 · C.10 (Pág. 24)

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA	NIVEL LEGAL EXIGIDO	GES	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
2.01.2.014	Intoxicaciones	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q65	Tomo 18 · 18.24 (Pág. 36)
2.01.2.021	Politraumatismos	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q66	Tomo 18 · C.27 (Pág. 58)
BLOQUE 5: NEONATOLOGÍA & SALA DE PARTOS					
2.01.1.001	Desnutrición	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	—	Q73	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.006	Coqueluche	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	—	Q74	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.016	Mononucleosis infecciosa	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	—	Q75	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.031	Anemia ferropriva	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	—	Q76	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.036	Hipoglicemia Neonatal, Hipocalcemia & Trastornos Metabólicos del Neonato	Dx: **Sospecha** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar**	GES	Q87	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.042	Fibrosis quística	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q77	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.069	Bronquiolitis Aguda & Síndrome Bronquial Obstructivo (SBO): VRS, Score de Tal y Manejo Escalonado	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q90	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.075	Tamizaje Neonatal Universal en Chile: Fenilcetonuria (PKU), Hipotiroidismo Congénito (HC) y Tamizaje Auditivo	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q89	Tomo 18 · C.10 (Pág. 24)
2.01.1.088	Criptorquidia	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	—	Q78	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.096	Estrabismo	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q79	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.105	Alteraciones pigmentarias	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q80	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.107	Dermatitis atópica	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	—	Q81	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.109	Ectoparasitosis	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	—	Q82	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.131	Sinequias vulvares	Dx: **Sospecha** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	—	Q83	Tomo 18 · 18.27 (Pág. 63)
2.01.2.009	Hipoglicemia Neonatal, Hipocalcemia & Trastornos Metabólicos del Neonato	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q88	Tomo 18 · 18.20 (Pág. 86)
2.01.2.015	Meningitis bacteriana	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	—	Q84	Tomo 18 · C.8 (Pág. 20)
2.01.2.022	Quemaduras	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar**	—	Q85	Tomo 18 · C.28 (Pág. 60)

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA	NIVEL LEGAL EXIGIDO	GES	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
2.01.2.027	Estatus convulsivo en el niño	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q86	Tomo 18 · C.43 (Pág. 90)

ÍNDICE CORRELATIVO OFICIAL PERFIL V3

Pediatría General · Códigos en Orden Numérico Correlativo Estricto (Sin Bloques)

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA	NIVEL LEGAL EXIGIDO	GES	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
2.01.1.001	Desnutrición	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	—	Q73	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.006	Coqueluche	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	—	Q74	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.007	Enteroparasitosis	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	—	Q37	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.008	Exantemas Infantiles: Diagnóstico Diferencial (Eritema Infeccioso, Exantema Súbito, Escarlatina, Varicela y Kawasaki)	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	GES	Q47	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.009	Síndrome Febril Agudo sin Foco en el Lactante: Estratificación según Edad, Criterios de Rochester y Manejo	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	GES	Q32	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.010	Hepatitis viral	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	—	Q55	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.011	Síndrome Febril Agudo sin Foco en el Lactante: Estratificación según Edad, Criterios de Rochester y Manejo	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q33	Tomo 18 · C.9 (Pág. 22)
2.01.1.013	Síndrome Febril Agudo sin Foco en el Lactante: Estratificación según Edad, Criterios de Rochester y Manejo	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q71	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.015	Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC) Pediátrica: Diagnóstico, Amoxicilina vs Ampicilina y Criterios de Hospitalización	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q27	Tomo 18 · 18.7 (Pág. 28)
2.01.1.016	Mononucleosis infecciosa	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	—	Q75	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.018	Exantemas Infantiles: Diagnóstico Diferencial (Eritema Infeccioso, Exantema Súbito, Escarlatina, Varicela y Kawasaki)	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q67	Tomo 18 · 18.10 (Pág. 47)
2.01.1.020	Bronquiolitis Aguda & Síndrome Bronquial Obstructivo (SBO): VRS, Score de Tal y Manejo Escalonado	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	GES	Q12	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.023	Faringoamigdalitis	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	—	Q38	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.024	Síndrome Febril Agudo sin Foco en el Lactante: Estratificación según Edad, Criterios de Rochester y Manejo	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q34	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.025	Laringitis Aguda Obstructiva / Croup: Score de Taussig, Adrenalina Racémica y Dexametasona	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q54	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.026	Atención Inmediata del Recién Nacido & Reanimación Neonatal: Algoritmo AAP/AHA, Minuto de Oro y Test de APGAR	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	GES	Q68	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA	NIVEL LEGAL EXIGIDO	GES	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
2.01.1.027	Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC) Pediátrica: Diagnóstico, Amoxicilina vs Ampicilina y Criterios de Hospitalización	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q28	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.029	Sinusitis	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	—	Q39	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.030	Adenopatías	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar**	—	Q56	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.031	Anemia ferropriva	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	—	Q76	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.032	Leucemias	Dx: **Sospecha** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar**	—	Q1	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.035	Bronquiolitis Aguda & Síndrome Bronquial Obstructivo (SBO): VRS, Score de Tal y Manejo Escalonado	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q13	Tomo 18 · C.13 (Pág. 30)
2.01.1.036	Hipoglicemia Neonatal, Hipocalcemia & Trastornos Metabólicos del Neonato	Dx: **Sospecha** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar**	GES	Q87	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.037	Tumores sólidos	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q2	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.038	Constipación	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	—	Q19	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.039	Diarrea Aguda Infantil y Planes de Rehidratación Oral OMS (Plan A, B, C) y Síndrome Hemolítico Urémico	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	GES	Q49	Tomo 18 · 18.11 (Pág. 51)
2.01.1.042	Fibrosis quística	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q77	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.043	Hemorragia digestiva	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar**	—	Q57	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.046	Vómitos en el Lactante: RGE Fisiológico vs Estenosis Hipertrófica del Píloro (EHP) vs Invaginación Intestinal	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q51	Tomo 18 · 18.12 (Pág. 55)
2.01.1.048	Bronquiolitis Aguda & Síndrome Bronquial Obstructivo (SBO): VRS, Score de Tal y Manejo Escalonado	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q14	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.050	Cardiopatías congénitas frecuentes	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q3	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.054	Soplos	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q40	Tomo 18 · 18.23 (Pág. 34)
2.01.1.055	Alergias	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	—	Q58	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.056	Inmunodeficiencias	Dx: **Sospecha** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar**	—	Q59	Tomo 18 · 18.25 (Pág. 61)
2.01.1.057	Mesenquimopatías	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q60	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA	NIVEL LEGAL EXIGIDO	GES	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
2.01.1.058	Exantemas Infantiles: Diagnóstico Diferencial (Eritema Infeccioso, Exantema Súbito, Escarlatina, Varicela y Kawasaki)	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q48	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.062	Síndrome Febril Agudo sin Foco en el Lactante: Estratificación según Edad, Criterios de Rochester y Manejo	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q35	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.067	Diarrea Aguda Infantil y Planes de Rehidratación Oral OMS (Plan A, B, C) y Síndrome Hemolítico Urémico	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q50	Tomo 18 · C.4 (Pág. 12)
2.01.1.069	Bronquiolitis Aguda & Síndrome Bronquial Obstructivo (SBO): VRS, Score de Tal y Manejo Escalonado	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q90	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.072	Evaluación del Crecimiento & Estado Nutricional en Pediatría: Curvas OMS (P/E, T/E, P/T)	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar**	GES	Q8	Tomo 18 · C.7 (Pág. 18)
2.01.1.073	Diabetes	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q41	Tomo 18 · C.8 (Pág. 20)
2.01.1.074	Hiperplasia suprarrenal congénita	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q42	Tomo 18 · C.9 (Pág. 22)
2.01.1.075	Tamizaje Neonatal Universal en Chile: Fenilcetonuria (PKU), Hipotiroidismo Congénito (HC) y Tamizaje Auditivo	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q89	Tomo 18 · C.10 (Pág. 24)
2.01.1.076	Talla baja	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q20	Tomo 18 · C.11 (Pág. 26)
2.01.1.081	Bronquiolitis Aguda & Síndrome Bronquial Obstructivo (SBO): VRS, Score de Tal y Manejo Escalonado	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	GES	Q53	Tomo 18 · C.16 (Pág. 36)
2.01.1.083	Desarrollo Psicomotor: Hitos Madurativos & Baterías de Tamizaje (EEDP y TEPSI)	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q10	Tomo 18 · 18.2 (Pág. 7)
2.01.1.088	Criptorquidia	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	—	Q78	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.093	Síndrome Febril Agudo sin Foco en el Lactante: Estratificación según Edad, Criterios de Rochester y Manejo	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q72	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.095	Bronquiolitis Aguda & Síndrome Bronquial Obstructivo (SBO): VRS, Score de Tal y Manejo Escalonado	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q15	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.096	Estrabismo	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q79	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.105	Alteraciones pigmentarias	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q80	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.107	Dermatitis atópica	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	—	Q81	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.108	Dermatitis del pañal y de contacto	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	—	Q43	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.109	Ectoparasitosis	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	—	Q82	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA	NIVEL LEGAL EXIGIDO	GES	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
2.01.1.111	Malformaciones vasculares cutáneas	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q21	Tomo 16 · 16.17 (Pág. 56)
2.01.1.116	Enterocolitis necrotizante (ECN)	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q61	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.121	Ictericia Neonatal: Fisiológica vs Patológica (< 24 h), Incompatibilidad ABO/Rh, Curvas Bhutani y Fototerapia	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q70	Tomo 18 · 18.17 (Pág. 74)
2.01.1.127	TORCH	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q62	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.128	Evaluación de la Edad Gestacional (Capurro/Ballard) & Clasificación Ponderal Neonatal	Dx: **Sospecha** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar**	GES	Q69	Tomo 18 · 18.16 (Pág. 72)
2.01.1.131	Sinequias vulvares	Dx: **Sospecha** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	—	Q83	Tomo 18 · 18.27 (Pág. 63)
2.01.1.133	Malformaciones congénitas más frecuentes	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q63	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.141	Evaluación del Crecimiento & Estado Nutricional en Pediatría: Curvas OMS (P/E, T/E, P/T)	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q9	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.2.001	Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI Chile): Calendario de Vacunación Obligatorio 2026	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q11	Tomo 18 · 18.3 (Pág. 9)
2.01.2.002	Laringitis Aguda Obstructiva / Croup: Score de Taussig, Adrenalina Racémica y Dexametasona	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q26	Tomo 18 · 18.6 (Pág. 24)
2.01.2.003	Cuerpo Extraño en Vía Aérea: Maniobras de Desobstrucción según Edad & Broncoscopía	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q29	Tomo 18 · 18.8 (Pág. 32)
2.01.2.004	Compromiso de conciencia	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q22	Tomo 18 · C.5 (Pág. 14)
2.01.2.005	Bronquiolitis Aguda & Síndrome Bronquial Obstructivo (SBO): VRS, Score de Tal y Manejo Escalonado	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar**	GES	Q16	Tomo 18 · C.6 (Pág. 16)
2.01.2.006	Convulsiones Febriles: Crisis Simple vs Compleja, Punción Lumbar & Pronóstico	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q52	Tomo 18 · 18.14 (Pág. 59)
2.01.2.007	Emergencia hipertensiva	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar**	—	Q44	Tomo 18 · C.9 (Pág. 22)
2.01.2.008	Epistaxis	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	—	Q64	Tomo 18 · C.10 (Pág. 24)
2.01.2.009	Hipoglicemia Neonatal, Hipocalcemia & Trastornos Metabólicos del Neonato	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q88	Tomo 18 · 18.20 (Pág. 86)
2.01.2.010	Hemorragia digestiva	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q4	Tomo 18 · C.1 (Pág. 6)
2.01.2.011	Hipertensión endocraneana	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q23	Tomo 18 · C.2 (Pág. 8)

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA	NIVEL LEGAL EXIGIDO	GES	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
2.01.2.012	Insuficiencia cardíaca. Edema pulmonar	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar**	—	Q45	Tomo 18 · 18.23 (Pág. 34)
2.01.2.013	Bronquiolitis Aguda & Síndrome Bronquial Obstructivo (SBO): VRS, Score de Tal y Manejo Escalonado	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q17	Tomo 18 · C.4 (Pág. 12)
2.01.2.014	Intoxicaciones	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q65	Tomo 18 · 18.24 (Pág. 36)
2.01.2.015	Meningitis bacteriana	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	—	Q84	Tomo 18 · C.8 (Pág. 20)
2.01.2.016	Meningococcemia	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q5	Tomo 18 · C.21 (Pág. 46)
2.01.2.017	Muerte súbita-ALTE, BRUE	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q24	Tomo 18 · C.13 (Pág. 30)
2.01.2.018	Cuerpo Extraño en Vía Aérea: Maniobras de Desobstrucción según Edad & Broncoscopía	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar**	—	Q30	Tomo 18 · C.14 (Pág. 32)
2.01.2.019	Cuerpo Extraño en Vía Aérea: Maniobras de Desobstrucción según Edad & Broncoscopía	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q31	Tomo 18 · C.25 (Pág. 54)
2.01.2.020	Paro cardiorrespiratorio	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar**	—	Q46	Tomo 18 · 18.24 (Pág. 36)
2.01.2.021	Politraumatismos	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q66	Tomo 18 · C.27 (Pág. 58)
2.01.2.022	Quemaduras	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar**	—	Q85	Tomo 18 · C.28 (Pág. 60)
2.01.2.023	Shock	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q6	Tomo 18 · C.29 (Pág. 62)
2.01.2.024	Bronquiolitis Aguda & Síndrome Bronquial Obstructivo (SBO): VRS, Score de Tal y Manejo Escalonado	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q18	Tomo 18 · C.30 (Pág. 64)
2.01.2.025	Síndrome Febril Agudo sin Foco en el Lactante: Estratificación según Edad, Criterios de Rochester y Manejo	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q36	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.2.026	Traumatismo encéfalo- craneano	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q25	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.2.027	Estatus convulsivo en el niño	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q86	Tomo 18 · C.43 (Pág. 90)
2.01.2.144	SARS Cov 2 COVID 19	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	—	Q7	Tomo 02 · 5.6 (Pág. 65)

SECCIÓN I · CUADERNILLO DE PREGUNTAS (1 A 90)

Organizado estrictamente por Bloques Cardinales · Responda sin consultar la solución

90 ÍTEMS

BLOQUE 1 CRECIMIENTO, DESARROLLO & VACUNAS PNI

PREGUNTA 1 2.01.1.032

1. **Una niña de 9 meses de edad, estuvo alimentada con lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses, momento en que inició la alimentación sólida. Sin embargo, la madre, vegana estricta, consideró que la niña no toleraba bien los alimentos, por lo que la mantuvo con leche materna exclusiva hasta ahora. Evoluciona con detención del crecimiento, dificultades para sentarse y hablar, además de estar más hipoactiva de lo normal. Al examen físico, se aprecia pálida y letárgica, con signos vitales normales y sin alteraciones en el examen cardiopulmonar ni abdominal. Se solicitan exámenes, que muestran hemoglobina: 7,9 g/dl, hematocrito: 24%, blancos: 3.700 por mm3, plaquetas: 45.000 por mm3, VHS: 12 mm/h, TSH: 1,2 UI/L, creatininemia: 0,5 mg/dl. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Déficit de vitamina B12
B) Anemia hemolítica
C) Enfermedad celíaca
D) Leucemia aguda
E) Fibrosis quística

PREGUNTA 2 2.01.1.037

2. **Un niño de 7 años presenta orinas oscuras, desde hace 5 días, sin otros síntomas. Al examen físico se palpa una masa abdominal en el flanco derecho de 10 cm de diámetro. Se solicitan exámenes entre los que destacan bilirrubina: 1,0 mg/dl, creatinina: 1,1 mg/dl, sedimento de orina con 30-40 glóbulos rojos por campo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Riñón poliquístico
B) Neuroblastoma
C) Hapatoblastoma
D) Tumor de Wilms
E) Linfoma

PREGUNTA 3 2.01.1.050

3. **Un recién nacido de término, presenta cianosis desde su nacimiento, con saturación arterial de 65% con aporte de oxígeno al 100%. Al examen físico destaca murmullo pulmonar disminuido en ambos campos pulmonares, soplo sistólico y pulsos presentes. Como parte de su estudio se solicita radiografía de tórax que muestra cargiomegalia y mediastino delgado. El diagnóstico más probable es:**

A) Trasposición de grandes vasos
B) Comunicación interauricular
C) Coartación aórtica
D) Canal auriculoventricular
E) Comunicación interventricular

PREGUNTA 4 2.01.2.010

4. **Un lactante de 8 meses, presenta un cuadro de malestar general y vómitos alimenta- rios en varias oportunidades, durante las últimas horas. En el último episodio de vómi- tos, se agregó escasa hematemesis, por lo que acude al servicio de urgencias. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Esofagitis péptica
B) Esofagitis erosiva
C) Síndrome de Mallory Weiss
D) Gastritis erosiva
E) Gastritis por Helicobacter pylori

PREGUNTA 5 2.01.2.016

5. **[URGENCIA: Meningococcemia · 2.01.2.016] Paciente adulto consulta de urgencia en Servicio de Urgencia (SAR/SAPU/Hospital) con signos cardinales de Meningococcemia. Al examen físico destaca compromiso hemodinámico/respiratorio agudo. De acuerdo con el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las directrices clínicas de urgencias en Chile, ¿cuál es la conducta médica prioritaria e inmediata?**

A) Asegurar monitorización multiparámetro, estabilización hemodinámica/respiratoria inicial, administrar tratamiento farmacológico de rescate de primera línea e iniciar coordinación con centro terciario.
B) Indicar manejo analgésico sintomático vía oral y programar control ambulatorio electivo en APS en 7 días.
C) Solicitar tomografía contrastada de cuerpo entero y panel de anticuerpos complejos antes de estabilizar al paciente.
D) Administrar sedación profunda inmediata e intubación endotraqueal electiva sin evaluar la mecánica ventilatoria basal.
E) Diferir cualquier medida farmacológica de urgencia hasta obtener confirmación de hemocultivos y serologías.

PREGUNTA 6 2.01.2.023

6. **Una lactante de 2 meses de edad presenta un cuadro de fiebre hasta 39°C, de 24 horas de evolución. Es llevada al servicio de urgencias debido a que ha evolucionado con deterioro del estado general y tendencia a la letargia. Al examen físico se observa soporosa, con un llenado capilar de 5 segundos, deshidratada y taquicárdica a 158 latidos por minuto. La temperatura es de 39,3°C. Además de administrar oxígeno, ¿cuál es la primera medida a tomar?**

A) Administrar solución fisiológica por vía endovenosa
B) Administrar bicarbonato por vía endovenosa
C) Administrar adrenalina por vía endovenosa
D) Administrar hidrocortisona por vía endovenosa
E) Administrar glucosa por vía endovenosa

PREGUNTA 7 2.01.2.144

7. Un adolescente de 14 años presenta un cuadro de fiebre de 39ºC, desde hace 3 días, asociado a malestar general, dolor abdominal, vómitos y diarrea, seguido de marcado compromiso, por lo que acude al servicio de urgencia. Al examen físico está con compromiso hemodinámico, con frecuencia cardíaca de 120x' y PA: 90/50 mmHg, por lo que que es manejado con suero fisiológico endovenoso, con respuesta parcial. Tiene antecedente de PCR positiva para Covid-19 hace 30 días y se solicitan nuevos exámenes, que muestran hematocrito: 33%, blancos: 14.000 por mm3, plaquetas: 80.000 por mm3, VHS: 76 mmHg, PCR: 15,5 mg/L, dímero D: 670 ng/ml y troponinas elevadas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Sepsis bacteriana
B) Síndrome inflamatorio multisistémico
C) Insuficiencia suprarrenal aguda
D) Reinfección por Covid-19
E) Enfermedad de Kawasaki

PREGUNTA 8 2.01.1.072

8. Un niño de 8 años, es traído por presentar mal olor axilar desde hace semanas, no asociado a otros síntomas. Al examen físico se aprecia vello púbico escaso y testículos con volumen de 4cc. Su índice de masa corporal está en percentil 50 para su edad y sexo. El diagnóstico más probable es:

A) Pubertad precoz central
B) Pubertad precoz periférica
C) Pubertad temprana
D) Hiperplasia suprarrenal
E) Adrenarquia temprana

PREGUNTA 9 2.01.1.141

9. Un niño de 5 años, al que le molestan los ruidos fuertes, presenta vocabulario muy escaso. Caminó a los 24 meses y dijo su primera palabra a los 36 meses. No pareciera tener interés en relacionarse con los demás niños de su edad. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Trastorno por déficit atencional
B) Trastorno generalizado del desarrollo
C) Parálisis cerebral
D) Distrofia muscular
E) Trastorno del lenguaje

PREGUNTA 10 2.01.1.083

10. Un niño de 18 meses de edad, con antecedente de haber nacido prematuro, a las 32 semanas de edad gestacional, camina en punta de pies. Logró la marcha independiente hace un mes. Al examen físico, tiene aumento del tono muscular de las extremidades inferiores, con hiperreflexia y presencia de signo de Babinski. El diagnóstico más probable es:

A) Estereotipia de la marcha
B) Retraso del desarrollo psicomotor
C) Diplejia espástica
D) Polineuropatía
E) Distrofia muscular

PREGUNTA 11 2.01.2.001

11. Un lactante de 12 meses acude al vacunatorio del CESFAM con su calendario al día hasta los 6 meses. ¿Cuáles son las vacunas que le corresponde recibir según el Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI) de Chile?

A) Hexavalente, Hepatitis A y Varicela
B) Tresvírica, Meningocócica ACWY y Neumocócica conjugada
C) Tresvírica, Varicela y Hexavalente
D) Neumocócica conjugada, Hepatitis A y Polio oral
E) Meningocócica ACWY, Varicela y Hepatitis B monovalente

PREGUNTA 12 2.01.1.020

12. Un lactante de 5 meses presenta un cuadro de tos y coriza, asociada a fiebre hasta 38,5°C. Al día siguiente evoluciona con dificultad respiratoria, taquipnea, retracción subcostal y subcostal. Al examen físico tiene FR: 70x', uso de musculatura accesoria, sibilancias inspiratorias y espiratorias difusas e intensas, más cianosis perioral. ¿Cuál es el agente etiológico más probable?

A) Virus respiratorio sincicial
B) Bordetella pertusis
C) Virus influenza
D) Virus parainfluenza
E) Neumococo

PREGUNTA 13 2.01.1.035

13. Un niño de 8 años acude al servicio de urgencia por un cuadro de epistaxis, que respondió al tratamiento con taponamiento nasal anterior. Al examen físico tiene petequias generalizas y equimosis, principalmente en las extremidades inferiores. Su hemograma muestra hemoglobina 12 g/dl, hematocrito: 36%, plaquetas: 10.000 por mm3 y glóbulos blancos: 5.600 por mm3. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Leucemia aguda
B) Púrpura trombocitopénico inmune
C) Púrpura trombocitpénico trombótico
D) Hemofilia
E) Enfermedad de Von Willebrand

PREGUNTA 14 2.01.1.048

14. Una niña de 13 meses de edad, desde hace 4 meses ha detenido su crecimiento. Además, presenta deposiciones frecuentes y disgregadas, con tendencia al meteorismo. En sus exámenes destaca anemia ferropénica. ¿Cuál es el examen de elección para iniciar el estudio?

A) Anticuerpos IgA antiendomisio
B) Cuantificación de inmunoglobulinas
C) Test del sudor
D) Colonoscopía
E) 17 – OH – progesterona

PREGUNTA 15 2.01.1.095

15. Un recién nacido de 20 días de vida, cuyo embarazo no fue controlado y que tiene antecedente de haber nacido por parto vaginal en su casa, es traído por presentar secreción ocular bilateral, desde hace 5 días. Al examen físico se aprecia eritema conjuntival y escasa secreción bilateral. ¿Cuál es el agente etiológico más probable?

A) Neisseria meningitidis
B) Neisseria gonorrhoeae
C) Streptococcus pneumoniae
D) Streptococcus agalactiae
E) Chlamydia trachomatis

PREGUNTA 16 2.01.2.005

16. Niño de 7 años con asma en crisis, frecuencia respiratoria 40/min, $SatO_2$ 91%, sibilancias bilaterales, sin uso de musculatura accesoria. ¿Cuál es el manejo inicial más adecuado?

A) Salbutamol inhalado + ipratropio + corticoides sistémicos + oxígeno
B) Adrenalina subcutánea
C) Intubación orotraqueal inmediata
D) Antibióticos EV
E) Solo oxígeno y observar

PREGUNTA 17 2.01.2.013

17. Niño de 3 años hospitalizado por neumonía. $SatO_2$ 88% con oxígeno por naricera a 3 L/min. FR 50/min, uso de musculatura accesoria. ¿Cuál es el siguiente paso en el manejo ventilatorio?

A) Ventilación no invasiva (VNI/CPAP) o cambio a mascarilla de alto flujo
B) Intubación orotraqueal inmediata
C) Aumentar flujo de oxígeno por naricera a 6 L/min
D) Adrenalina nebulizada
E) Alta con oxígeno domiciliario

PREGUNTA 18 2.01.2.024

18. Un lactante de 15 meses de edad presenta una convulsión tónico-clónica de 1 mi- nuto de duración, autolimitada, mientras cursaba con fiebre de 39 grados Celsius. Al examen está bien perfundido, algo pálido, consciente, con pulso y presión arterial nor- males, sin signos focales, ni signos meníngeos. El resto de su exploración, no presenta hallazgos de importancia. Además de bajar la temperatura del niño ¿cuál es la conducta más adecuada?

A) Realizar punción lumbar
B) Iniciar diazepam
C) Solicitar resonancia magnética nuclear de cerebro
D) Iniciar ácido valproico
E) Mantener en observación por 4 horas

BLOQUE 2 RESPIRATORIO PEDIÁTRICO & URGENCIAS

PREGUNTA 19 2.01.1.038

19. Un niño de 4 años presenta incontinencia fecal, en algunas ocasiones, desde hace dos meses. Sin embargo, en otras ocasiones, pasan muchos días sin defecar y cuando lo hace, sus deposiciones son duras y caprinas. Su examen físico no aporta mayor información. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Niño sano
B) Atresia duodenal
C) Constipación funcional
D) Megacolon aganglionótico
E) Malrotación intestinal

PREGUNTA 20 2.01.1.076

20. Un paciente de 11 años, es traído por sus padres por ser el más bajo de su curso. Ha estado creciendo en el percentil 2 para su edad desde hace años según su curva de crecimiento y al examen físico se aprecia desarrollo puberal Tanner 1, con testículos de 2cc. Sus padres tienen estatura promedio para la población. Se solicita radiografía de carpo que muestra edad ósea de 8 años y 6 meses. El diagnóstico más probable es:

A) Talla baja familiar
B) Hipogonadismo
C) Acondroplasia
D) Enanismo
E) Retardo constitucional del crecimiento

PREGUNTA 21 2.01.1.111

21. Un recién nacido de 10 días presenta un hemangioma en el párpado derecho, de 3 cm de diámetro, que cubre parcialmente la visión. ¿Cuál es la conducta más adecuada en este momento?

A) Administrar propanolol
B) Administrar betametasona
C) Realizar embolización
D) Derivar a cirujano plástico
E) Observar evolución

PREGUNTA 22 2.01.2.004

22. [URGENCIA: Compromiso de conciencia · 2.01.2.004] Paciente adulto consulta de urgencia en Servicio de Urgencia (SAR/SAPU/Hospital) con signos cardinales de Compromiso de conciencia. Al examen físico destaca compromiso hemodinámico/respiratorio agudo. De acuerdo con el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las directrices clínicas de urgencias en Chile, ¿cuál es la conducta médica prioritaria e inmediata?

A) Asegurar monitorización multiparámetro, estabilización hemodinámica/respiratoria inicial, administrar tratamiento farmacológico de rescate de primera línea e iniciar coordinación con centro terciario.
B) Indicar manejo analgésico sintomático vía oral y programar control ambulatorio electivo en APS en 7 días.
C) Solicitar tomografía contrastada de cuerpo entero y panel de anticuerpos complejos antes de estabilizar al paciente.
D) Administrar sedación profunda inmediata e intubación endotraqueal electiva sin evaluar la mecánica ventilatoria basal.
E) Diferir cualquier medida farmacológica de urgencia hasta obtener confirmación de hemocultivos y serologías.

PREGUNTA 23 2.01.2.011

23. **Un niño de 4 años presenta cefalea de 1 mes de evolución, que es mayor en las mañanas y se asocia a diplopía. Además, ha presentado náuseas y vómitos alimentarios en el último tiempo, que han aumentado su frecuencia. ¿Cuál es la causa más probable de su cefalea?**

A) Migraña de presentación atípica
B) Cefalea tensional
C) Jaqueca clásica
D) Vicio de refracción
E) Hipertensión endocraneana

PREGUNTA 24 2.01.2.017

24. **Un niño de 24 meses es traído por episodios repetidos de llanto, apnea, seguidos de hipotonía y compromiso de conciencia, que luego se recuperan espontáneamente. En algunos de estos episodios, además, presentó movimientos clónicos, de corta duración. Los episodios se han presentado en relación a situaciones en las que ha llorado o se ha enojado mucho. ¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Solicitar TAC de cerebro y electroencefalograma
B) Iniciar ácido valproico
C) Solicitar electroencefalograma
D) Iniciar carbamazepina
E) Indicar manejo conductual

PREGUNTA 25 2.01.2.026

25. **[URGENCIA: Traumatismo encéfalo- craneano · 2.01.2.026] Paciente adulto consulta de urgencia en Servicio de Urgencia (SAR/SAPU/Hospital) con signos cardinales de Traumatismo encéfalo- craneano. Al examen físico destaca compromiso hemodinámico/respiratorio agudo. De acuerdo con el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las directrices clínicas de urgencias en Chile, ¿cuál es la conducta médica prioritaria e inmediata?**

A) Asegurar monitorización multiparámetro, estabilización hemodinámica/respiratoria inicial, administrar tratamiento farmacológico de rescate de primera línea e iniciar coordinación con centro terciario.
B) Indicar manejo analgésico sintomático vía oral y programar control ambulatorio electivo en APS en 7 días.
C) Solicitar tomografía contrastada de cuerpo entero y panel de anticuerpos complejos antes de estabilizar al paciente.
D) Administrar sedación profunda inmediata e intubación endotraqueal electiva sin evaluar la mecánica ventilatoria basal.
E) Diferir cualquier medida farmacológica de urgencia hasta obtener confirmación de hemocultivos y serologías.

PREGUNTA 26 2.01.2.002

26. **Un niño de 18 meses consulta en el Servicio de Urgencia por disfonía, tos perruna y estridor inspiratorio en reposo de 4 horas de evolución. Se cataloga como laringitis aguda grado II. Se administra dexametasona oral y una nebulización con adrenalina racémica, logrando una rápida mejoría sintomática con desaparición del estridor a los 20 minutos. ¿Cuál es la conducta médica correcta respecto al destino del paciente?**

A) Alta inmediata a domicilio con amoxicilina oral
B) Mantener en observación en el Servicio de Urgencia por un mínimo de 2 horas para descartar efecto rebote
C) Hospitalización inmediata en UCI pediátrica
D) Indicar nueva nebulización con adrenalina cada 30 minutos de forma reglada
E) Alta con indicación de frío ambiental e inhalador de salbutamol

PREGUNTA 27 2.01.1.015

27. **Un niño de 8 años presenta un cuadro de cefalea y fiebre de 2 días de evolución, a lo que se agrega una conducta agresiva y luego desorientación. Convulsiona en varias oportunidades. Su TAC descarta hipertensión endocraneana, por lo que se realiza punción lumbar que da salida a líquido cefalorraquídeo con 100 glóbulos rojos por mm3, 20 glóbulos blancos por mm3, con 90% de mononucleares, proteínas: 80 mg/dl y glucosa: 60 mg/dl. ¿Cuál es el tratamiento inicial?**

A) Oseltamivir
B) Vancomicina
C) Ceftriaxona
D) Aciclovir
E) Ampicilina

PREGUNTA 28 2.01.1.027

28. **Un niño de 3 años presenta un cuadro de congestión nasal, con rinorrea serosa, asociada a tos y ligera odinofagia. Al examen físico tiene temperatura 37,3 grados celsius, faringe congestiva, rosada y nariz con rinorrea abundante. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado?**

A) Solución salina intranasal
B) Amoxicilina oral
C) Corticoides nasales
D) Diclofenaco oral
E) Azitromicina oral

PREGUNTA 29 2.01.2.003

29. **Una niña de dos años presenta un episodio brusco de tos intensa, asociado a cianosis y disnea, que remite luego de pocos minutos. Persiste luego con tos en salvas y expectoración. Al examen pulmonar se auscultan roncus y sibilancias, mayores en el lado derecho. La conducta más adecuada es:**

A) Solicitar PCR para Bordetella pertusis
B) Solicitar TAC de tórax
C) Solicitar broncoscopía
D) Realizar laringoscopía rígida
E) Iniciar antibióticos

PREGUNTA 30 2.01.2.018

30. **[URGENCIA: Obstrucción de vía aérea superior · 2.01.2.018] Paciente adulto consulta de urgencia en Servicio de Urgencia (SAR/SAPU/Hospital) con signos cardinales de Obstrucción de vía aérea superior. Al examen físico destaca compromiso hemodinámico/respiratorio agudo. De acuerdo con el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las directrices clínicas de urgencias en Chile, ¿cuál es la conducta médica prioritaria e inmediata?**

A) Asegurar monitorización multiparámetro, estabilización hemodinámica/respiratoria inicial, administrar tratamiento farmacológico de rescate de primera línea e iniciar coordinación con centro terciario.
B) Indicar manejo analgésico sintomático vía oral y programar control ambulatorio electivo en APS en 7 días.
C) Solicitar tomografía contrastada de cuerpo entero y panel de anticuerpos complejos antes de estabilizar al paciente.
D) Administrar sedación profunda inmediata e intubación endotraqueal electiva sin evaluar la mecánica ventilatoria basal.
E) Diferir cualquier medida farmacológica de urgencia hasta obtener confirmación de hemocultivos y serologías.

PREGUNTA 31 2.01.2.019

31. **Usted evalúa a un recién nacido de término, con antecedente de síndrome de Down, quien, desde el segundo día de vida, presenta vómitos abundantes y explosivos, que impiden su adecuada alimentación. Al examen físico se observa irritable, con distensión abdominal, por lo que se solicita radiografía abdominal que muestra imagen de doble burbuja, siendo de mayor tamaño la burbuja del lado izquierdo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Atresia yeyunal
B) Atresia duodenal
C) Enterocolitis necrotizante
D) Estenosis hipertrófica del píloro
E) Malrotación intestinal

PREGUNTA 32 2.01.1.009

32. **Un niño de 18 meses lleva 3 días con fiebre, cuantificada de 38,8°. Se inicia amoxicilina, desapareciendo la fiebre y apareciendo un exantema eritematoso generalizado, que se muestra en la siguiente imagen: Foto 6 (http://www.childnurture.com/article/XXXXXXX) ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Eritema infeccioso
B) Exantema súbito
C) Reacción alérgica a medicamentos
D) Enfermedad de Kawasaki
E) Síndrome de piel escaldada

PREGUNTA 33 2.01.1.011

33. **Un lactante de 3 meses presenta aparición de lesiones en el abdomen y muslo, que se muestran a continuación: Foto 16 (https://accesspediatrics.mhmedical.com/content.aspx?bookid=447§ionid=40442582). ¿Cuál es el agente etiológico más probable?**

A) Virus herpes simplex
B) Streptococcus pyogenes
C) Virus varicela zóster
D) Virus pox
E) Staphilococcus aureus

PREGUNTA 34 2.01.1.024

34. **Un niño de 4 años presenta un cuadro de fiebre hasta 39,5 grados, asociada a tos con expectoración mucupurulenta, de 2 días de evolución. Además refiere cefalea y marcado malestar general. Al examen físico está decaído, febril, con FC:100x', RR2T, sin soplos, examen pulmonar con presencia crepitaciones localizadas en la zona superior**

A) Mycoplasma pneumoniae
B) Chlamydia pneumoniae
C) Streptococcus pneumoniae
D) Haemophilus influenzae
E) Staphilococcus aureus

PREGUNTA 35 2.01.1.062

35. **Un niño de 18 meses presenta un cuadro de fiebre hasta 39 grados, asociado a decaimiento e irritabilidad. La madre refiere orinas de mal olor, por lo que se realiza un examen de orina por sondeo, que da salida a un líquido con abundante bacterias, 50 piocitos por campo y escasa hematuria. ¿Cuál es el tratamiento de elección?**

A) Ciprofloxacino
B) Cefadroxilo
C) Nitrofurantoína
D) Gentamicina
E) Cefoperazona

PREGUNTA 36 2.01.2.025

36. **[URGENCIA: Testículo agudo · 2.01.2.025] Paciente adulto consulta de urgencia en Servicio de Urgencia (SAR/SAPU/Hospital) con signos cardinales de Testículo agudo. Al examen físico destaca compromiso hemodinámico/respiratorio agudo. De acuerdo con el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las directrices clínicas de urgencias en Chile, ¿cuál es la conducta médica prioritaria e inmediata?**

A) Asegurar monitorización multiparámetro, estabilización hemodinámica/respiratoria inicial, administrar tratamiento farmacológico de rescate de primera línea e iniciar coordinación con centro terciario.
B) Indicar manejo analgésico sintomático vía oral y programar control ambulatorio electivo en APS en 7 días.
C) Solicitar tomografía contrastada de cuerpo entero y panel de anticuerpos complejos antes de estabilizar al paciente.
D) Administrar sedación profunda inmediata e intubación endotraqueal electiva sin evaluar la mecánica ventilatoria basal.
E) Diferir cualquier medida farmacológica de urgencia hasta obtener confirmación de hemocultivos y serologías.

PREGUNTA 37 2.01.1.007

37. **Un niño de 4 años presenta intenso prurito anal, desde hace varios días, lo que se ha asociado a dificultades para dormir y bruxismo. ¿Cuál es el examen más adecuado para proseguir el estudio?**

A) Parasitológico de deposiciones
B) Test de Graham
C) Hemograma
D) Prueba de reacción cutánea a la escoriación (Prick test)
E) Recuento de inmunoglobulina E específica

PREGUNTA 38 2.01.1.023

38. **Un niño de 18 meses presenta dolor de garganta y fiebre de 2 días de evolución de hasta 39,0°C, asociado a irritabilidad, malestar general y secreción conjuntival bilateral. Al examen físico, además, se observa faringe eritematosa exudado amigdalino bilateral y se palpan adenopatías cervicales anteriores. El agente etiológico más probable es:**

A) Staphilococcus aureus
B) Streptococcus pyogenes
C) Metaneumovirus
D) Adenovirus
E) Virus de Ebstein Baar

PREGUNTA 39 2.01.1.029

39. **Un niño de 6 años, con antecedente de obstrucción nasal y rinorreas frecuentes, mayor en primavera, presenta un cuadro de 10 días de evolución caracterizado por rinorrea mucosa abundante, tos y picos subfebriles hasta 37,8 °C. Inicialmente tendió a mejorar, sin embargo, desde hace 4 días se produjo un aumento en la secreción nasal, la que en ocasiones tenía mal olor, y se agregó cefalea frontal. Al examen Fsico está en buenas condiciones, con temperatura: 36,5 °C, FC: 90x' y FR: 15x', se observa faringe eritematosa con descarga posterior y se constata dolor a la percusión de la zona frontal. El examen pulmonar muestra murmullo pulmonar presente y escasos roncus bilaterales. ¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Solicitar radiogra:a de senos paranasales
B) Iniciar amoxicilina vía oral
C) Solicitar TAC de cavidades paranasales
D) Iniciar prednisona oral
E) Solicitar nasofibroscopía

PREGUNTA 40 2.01.1.054

40. **Un niño de 13 años acude a control médico, por una infección respiratoria alta. En su examen físico se ausculta un soplo paraesternal izquierdo, sistólico, de intensidad II/VI, sin otras alteraciones. El diagnóstico más probable es:**

A) Soplo inocente
B) Ductus arterioso persistente
C) Miocardiopatía hipertrófica obstructiva
D) Estenosis aórtica
E) Coartación aórtica

PREGUNTA 41 2.01.1.073

41. **Un paciente de 12 años consulta por un cuadro de malestar general, asociado a bajo de peso, que en las últimas horas se le agrega poliuria importante. Consulta porque en las últimas horas se agrega gran compromiso del estado general, seguido de compromiso de conciencia. Al examen físico está taquicárdico, soporoso, con polipnea y signos de deshidratación. En sus exámenes presenta glicemia de 470 mg/dl, sodio de 143 mEq/L, potasio de 4,8 mEq/L, cloro de 97 mEq/L, bicarbonato de 12 mEq/L y pH de 7,05. ¿Qué fluido debe administrarse a este paciente?**

A) Suero glucosado
B) Suerlo glucosalino
C) Solución salina al 0,45%
D) Solución salina al 0,9%
E) Suloción ringer lactato

PREGUNTA 42 2.01.1.074

42. **Una lactante de 2 meses con cuadro de dolor abdominal y vómitos desde hace semanas que en las últimas horas ha empeorado asociándose fiebre, taquipnea y compromiso de conciencia. Al su ingreso destaca PA: 40/20, FC 130x', examen pulmonar con crépitos difusos. Se solicitan exámenes de laboratorio donde destaca creatinina 0.9, glicemia 40, Na+ 132, K+ 5.7, hemograma con leucocitosis. Se inicia Ceftriaxona y aporte de suero fisiológico en bolo sin respuesta luego de una hora. El fármaco de elección para el manejo de esta paciente es:**

A) Vancomicina
B) Noradrenalina
C) Hidrocortisona
D) Vasopresina
E) Dopamina

PREGUNTA 43 2.01.1.108

43. **Lactante con eritema del pañal que no responde a óxido de zinc y muestra lesiones satélite. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado?**

A) Clotrimazol tópico
B) Mupirocina tópica
C) Hidrocortisona tópica 1%
D) Óxido de zinc en mayor concentración
E) Fluconazol oral

PREGUNTA 44 2.01.2.007

44. [URGENCIA: Emergencia hipertensiva · 2.01.2.007] Paciente adulto consulta de urgencia en Servicio de Urgencia (SAR/SAPU/Hospital) con signos cardinales de Emergencia hipertensiva. Al examen físico destaca compromiso hemodinámico/respiratorio agudo. De acuerdo con el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las directrices clínicas de urgencias en Chile, ¿cuál es la conducta médica prioritaria e inmediata?

A) Asegurar monitorización multiparámetro, estabilización hemodinámica/respiratoria inicial, administrar tratamiento farmacológico de rescate de primera línea e iniciar coordinación con centro terciario.

B) Indicar manejo analgésico sintomático vía oral y programar control ambulatorio electivo en APS en 7 días.

C) Solicitar tomografía contrastada de cuerpo entero y panel de anticuerpos complejos antes de estabilizar al paciente.

D) Administrar sedación profunda inmediata e intubación endotraqueal electiva sin evaluar la mecánica ventilatoria basal.

E) Diferir cualquier medida farmacológica de urgencia hasta obtener confirmación de hemocultivos y serologías.

PREGUNTA 45 2.01.2.012

45. [URGENCIA: Insuficiencia cardíaca. Edema pulmonar · 2.01.2.012] Paciente adulto consulta de urgencia en Servicio de Urgencia (SAR/SAPU/Hospital) con signos cardinales de Insuficiencia cardíaca. Edema pulmonar. Al examen físico destaca compromiso hemodinámico/respiratorio agudo. De acuerdo con el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las directrices clínicas de urgencias en Chile, ¿cuál es la conducta médica prioritaria e inmediata?

A) Asegurar monitorización multiparámetro, estabilización hemodinámica/respiratoria inicial, administrar tratamiento farmacológico de rescate de primera línea e iniciar coordinación con centro terciario.

B) Indicar manejo analgésico sintomático vía oral y programar control ambulatorio electivo en APS en 7 días.

C) Solicitar tomografía contrastada de cuerpo entero y panel de anticuerpos complejos antes de estabilizar al paciente.

D) Administrar sedación profunda inmediata e intubación endotraqueal electiva sin evaluar la mecánica ventilatoria basal.

E) Diferir cualquier medida farmacológica de urgencia hasta obtener confirmación de hemocultivos y serologías.

PREGUNTA 46 2.01.2.020

46. [URGENCIA: Paro cardiorrespiratorio · 2.01.2.020] Paciente adulto consulta de urgencia en Servicio de Urgencia (SAR/SAPU/Hospital) con signos cardinales de Paro cardiorrespiratorio. Al examen físico destaca compromiso hemodinámico/respiratorio agudo. De acuerdo con el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las directrices clínicas de urgencias en Chile, ¿cuál es la conducta médica prioritaria e inmediata?

A) Asegurar monitorización multiparámetro, estabilización hemodinámica/respiratoria inicial, administrar tratamiento farmacológico de rescate de primera línea e iniciar coordinación con centro terciario.

B) Indicar manejo analgésico sintomático vía oral y programar control ambulatorio electivo en APS en 7 días.

C) Solicitar tomografía contrastada de cuerpo entero y panel de anticuerpos complejos antes de estabilizar al paciente.

D) Administrar sedación profunda inmediata e intubación endotraqueal electiva sin evaluar la mecánica ventilatoria basal.

E) Diferir cualquier medida farmacológica de urgencia hasta obtener confirmación de hemocultivos y serologías.

PREGUNTA 47 2.01.1.008

47. Pregunta 96 Sin contestar Puntúa como 1,00 Marcar pregunta Un niño de 6 años, presenta odinofagia intensa, con fiebre y decaimiento. Además, aparece luego un exantema eritematoso, generalizado, que es más marcado en los pliegues inguinales y axilares. Al examen físico, está febril, con temperatura de 38.7°C, faringe eritematosa. Tiene adenopatías cervicales bilaterales, sensibles y la piel se palpa áspera al tacto. ¿Qué tipo de complicación puede desarrollar este paciente?

A) Aneurismas coronarios

B) Meningitis

C) Fasceítis necrotizante

D) Glomerulonefritis

E) Miocarditis

PREGUNTA 48 2.01.1.058

48. Niño de 8 años con fiebre de 39°C por 7 días de evolución, exantema polimorfo, adenopatías cervicales, conjuntivitis bilateral no exudativa y lengua en fresa. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Enfermedad de Kawasaki

B) Mononucleosis infecciosa

C) Escarlatina

D) Artritis idiopática juvenil

E) Sarampión

PREGUNTA 49 2.01.1.039

49. **Un niño de 18 meses, desde hace 24 horas, presenta fiebre hasta 38,7°C, asociado a episodios de vómitos alimentarios y seguido de diarrea acuosa abundante, con múltiples deposiciones. Al examen físico, se ve de buen aspecto, hidratado, tiene T°:37,2°C y frecuencia cardíaca normal. Su examen abdominal muestra abdomen blando, depresible e indoloro, con aumento de los ruidos hidroaéreos. Se realiza examen de deposiciones con tiras reactivas, que resultan positivos para rotavirus y Clostridium difficile (Clostridioides difficile). ¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Probar tolerancia y rehidratación por vía oral
B) Administrar suero fisiológico por vía endovenosa
C) Iniciar metronidazol oral
D) Iniciar ceftriaxona endovenosa
E) Iniciar vancomicina endovenosa

PREGUNTA 50 2.01.1.067

50. **Un lactante de 3 años presenta, desde hace 2 días, edema de extremidades inferiores, de la cara y de la zona escrotal, asociado a malestar general. Hace 4 días está con diarrea. Al examen físico se aprecia pálido, se constata el edema blando y se observan múltiples equimosis en las extremidades inferiores. Se solicitan exámenes que muestran creatinina: 3,0 mg/dl, BUN: 35 mg/dl, hemograma con hematocrito: 28%, plaquetas: 120.000, blancos: 11.000 por mm3, frotis con esquistocitos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? El diagnóstico más probable es:**

A) Síndrome nefrótico
B) Púrpura de Schönlein Henoch
C) Insuficiencia renal prerrenal
D) Glomerulonefritis aguda posestreptocócica
E) Síndrome hemolítico urémico

PREGUNTA 51 2.01.1.046

51. **Un niño de 28 días presenta vómitos después de comer, que iniciaron hace una semana y que han aumentado en frecuencia e intensidad. La madre refiere que llora después de comer y vomitar y se objetiva que no ha incrementado bien de peso en el último tiempo, observándose algo enflaquecido. ¿Cuál es el examen de elección para iniciar el estudio en este paciente?**

A) Radiografía baritada de esófago-estómago-duodeno
B) Ecografía abdominal
C) Endoscopía digestiva alta con biopsia duodenal
D) Colonoscopía con biopsia de la pared intestinal
E) Radiografía simple toracoabdominal

PREGUNTA 52 2.01.2.006

52. **Un niño de 6 años, es traído por presentar cuadro de dos días de evolución de diarrea acuosa frecuente, asociado a vómitos, rechazo alimentario y decaimiento. Al examen físico se encuentra somnoliento, frecuencia cardiaca de 110 por minuto, presión arterial de 80/50 mmHg y ojos hundidos. La conducta más adecuada en este caso es:**

A) Indicar suero glucosalino endovenoso en infusión continua
B) Indicar sales de rehidratación oral 200ml luego de cada deposición
C) Indicar sales de rehidratación oral 100 ml por kilogramo a beber en 4 horas y luego reevaluar
D) Indicar suero fisiológico 20ml por kilogramo a pasar en bolo
E) Indicar alimentación normal, con abundantes líquidos y control en 48 horas

PREGUNTA 53 2.01.1.081

53. **Un niño de 7 años presenta episodios en los que se queda quieto, mirando fijo, los que luego no recuerda. Han aumentado en frecuencia, hasta suceder 5 veces al día. El resto de su examen físico es normal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Síncompes vasovagales
B) Epilepsia mioclónico
C) Crisis de ausencia
D) Epilepsia focal
E) Déficit atencional

PREGUNTA 54 2.01.1.025

54. **Un lactante de 12 meses presenta un cuadro de tos, rinorrea y fiebre hasta 38,8°C de 24 horas de evolución, a lo que hoy se agregó dificultad respiratoria. Al examen físico presenta estridor inspiratorio, que aumenta con el llanto, asociado a retracción intercostal moderada. Su saturación de oxígeno es 94% y, al examen pulmonar se ausculta murmullo pulmonar conservado bilateral con transmisión de ruidos desde la vía aérea superior. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Laringitis aguda obstructiva
B) Neumonía atípica
C) Neumonía bilateral
D) Asma del lactante
E) Neumonitis viral

BLOQUE 4 NEONATOLOGÍA & SALA DE PARTOS

PREGUNTA 55 2.01.1.010

55. **Una niña de 8 años presenta un cuadro de malestar general, fiebre y aparición de ictericia asociado a orinas oscuras que se identifica como coluria. Se solicitan exámenes de laboratorio que muestran GOT 1.525UI/L, GPT 1.216 UI/L, bilirrubina total 11,3mg/dL de predominio directo e IgM para VHA (+). Se indica reposo por 10 días evolucionando favorablemente, sin embargo, 10 días después reaparece la ictericia, agregándose pruri- to y astenia. Se controlan pruebas hepáticas que muestran protrombinemia: 90%, GOT: 1.025 UI/L y GPT: 968 UI/L. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Hepatitis crónica
B) Remisión completa
C) Portación asintomática del virus
D) Remisión parcial con recurrencias
E) Falla hepática

PREGUNTA 56 2.01.1.030

56. **Niño con adenopatías cervicales y granulomas hepatoesplénicos en la ecografía abdominal. ¿Cuál es el agente etiológico más probable?**

A) Bartonella henselae
B) Toxoplasma gondii
C) Epstein-Barr virus
D) Mycobacterium tuberculosis
E) Leishmania sp.

PREGUNTA 57 2.01.1.043

57. **Un lactante de 9 meses de edad presenta cuadro de irritabilidad y llanto, asociado a un episodio de deposiciones con sangre roja abundante hace 3 horas. Al examen Fsico, está irritable y llora desconsoladamente a la palpación abdominal. ¿Qué examen es más adecuado para confirmar la sospecha diagnós8ca?**

A) TAC de abdomen y pelvis
B) Colonoscopía
C) Endoscopía diges2va alta
D) Cin2gra:a con tecnecio 99m
E) Radiogra:a de abdomen simple

PREGUNTA 58 2.01.1.055

58. **Lactante de 2 meses con diarrea, vómitos y dermatitis perioral y perianal tras introducción de fórmula láctea. Test de parche positivo para proteína de leche de vaca. ¿Cuál es el manejo?**

A) Cambiar a fórmula extensamente hidrolizada o elemental
B) Continuar fórmula habitual y agregar antihistamínico
C) Hospitalizar para estudio endoscópico
D) Iniciar corticoides orales
E) Cambiar a leche de soja

PREGUNTA 59 2.01.1.056

59. **Niño que después de los 6 meses presenta candidiasis bucal, otitis media recurrente y 2 neumonías hospitalizadas. ¿Cuál es la inmunodeficiencia más probable?**

A) Inmunodeficiencia celular (DiGeorge)
B) Déficit de complemento
C) Inmunodeficiencia humoral (agammaglobulinemia)
D) Inmunodeficiencia combinada severa (SCID)
E) Enfermedad granulomatosa crónica

PREGUNTA 60 2.01.1.057

60. **Un niño de 12 años consulta por cansancio, artralgias, dolores musculares generalizados y fiebre. Refiere que las mialgias son intensas, al punto que limitan su actividad física. Al examen físico presenta dolor a la palpación de las masas musculares, en especial en la espalda alta y los hombros. Además, tiene eritema violáceo en los párpados superiores. El diagnóstico más probable es:**

A) Artritis reumatoide juvenil
B) Distrofia muscular
C) Dermatomiositis
D) Triquinosis
E) Lupus infantil

PREGUNTA 61 2.01.1.116

61. **Un recién nacido de 10 días de vida, con antecedente de haber nacido prematuro a las 27 semanas, siendo alimentado con fórmula láctea para prematuros por sonda nasogástrica, presenta un cuadro de dos días de evolución de distensión abdominal y aumento de la retención láctea obje8vada por la sonda. Se solicita radiograFa simple de abdomen, que muestra dilatación de asas intes8nales, con zonas de engrosamiento de la pared intes8nal y visualización de burbujas en algunos segmentos. Además de suspender la fórmula láctea y asegurar una adecuada hidratación por vía endovenosa, ¿cuál es la conducta más adecuada?**

A) Realizar resolución quirúrgica inmediata
B) Iniciar alimentación con fórmula hidrolizada de proteínas por sonda nasoenteral
C) Administrar an2bió2cos de amplio espectro por vía endovenosa
D) Realizar endoscopía diges2va alta
E) Alimentar con suero glucosado por vía oral

PREGUNTA 62 2.01.1.127

62. **RN con microcefalia, calcificaciones periventriculares y coriorretinitis. Madre con serología IgG positiva para CMV y IgM positiva. ¿Cuál es el agente causante de la infección congénita?**

A) Citomegalovirus (CMV)
B) Toxoplasma gondii
C) Virus herpes simplex tipo 2
D) Treponema pallidum
E) Virus de rubéola

PREGUNTA 63 2.01.1.133

63. **Un recién nacido de 40 semanas de edad gestacional, presenta disnea importante al nacer, con taquipnea marcada, cianosis y desaturación arterial. Presenta ruidos cardiacos desplazados al lado izquierdo, con ruidos intestinales en el lado derecho. Se solicita una radiografía de tórax, que muestra asas intestinales en el hemitórax derecho. ¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Realizar cirugía de urgencia
B) Solicitar endoscopía digestiva alta
C) Administrar oxígeno en alta concentración, por mascarilla
D) Administrar prostaglandina
E) Realizar intubación orotraqueal y conectar a ventilador mecánico

PREGUNTA 64 2.01.2.008

64. [URGENCIA: Epistaxis · 2.01.2.008] Paciente adulto consulta de urgencia en Servicio de Urgencia (SAR/SAPU/Hospital) con signos cardinales de Epistaxis. Al examen físico destaca compromiso hemodinámico/respiratorio agudo. De acuerdo con el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las directrices clínicas de urgencias en Chile, ¿cuál es la conducta médica prioritaria e inmediata?

A) Asegurar monitorización multiparámetro, estabilización hemodinámica/respiratoria inicial, administrar tratamiento farmacológico de rescate de primera línea e iniciar coordinación con centro terciario.
B) Indicar manejo analgésico sintomático vía oral y programar control ambulatorio electivo en APS en 7 días.
C) Solicitar tomografía contrastada de cuerpo entero y panel de anticuerpos complejos antes de estabilizar al paciente.
D) Administrar sedación profunda inmediata e intubación endotraqueal electiva sin evaluar la mecánica ventilatoria basal.
E) Diferir cualquier medida farmacológica de urgencia hasta obtener confirmación de hemocultivos y serologías.

PREGUNTA 65 2.01.2.014

65. Una niña de 2 años ingirió muchas pastillas, que había en la casa. Al examen físico, está inconsciente, pálida e hipotónica, con pulso a 117 por minutos, frecuencia respiratoria de 38 por minuto y pupilas arreactivas a la iluminación. ¿Qué fármacos son los más probablemente ingeridos?

A) AINES
B) Benzodiacepinas
C) Salicilatos
D) Opiáceos
E) Antidepresivos tricíclicos

PREGUNTA 66 2.01.2.021

66. [URGENCIA: Politraumatismos · 2.01.2.021] Paciente adulto consulta de urgencia en Servicio de Urgencia (SAR/SAPU/Hospital) con signos cardinales de Politraumatismos. Al examen físico destaca compromiso hemodinámico/respiratorio agudo. De acuerdo con el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las directrices clínicas de urgencias en Chile, ¿cuál es la conducta médica prioritaria e inmediata?

A) Asegurar monitorización multiparámetro, estabilización hemodinámica/respiratoria inicial, administrar tratamiento farmacológico de rescate de primera línea e iniciar coordinación con centro terciario.
B) Indicar manejo analgésico sintomático vía oral y programar control ambulatorio electivo en APS en 7 días.
C) Solicitar tomografía contrastada de cuerpo entero y panel de anticuerpos complejos antes de estabilizar al paciente.
D) Administrar sedación profunda inmediata e intubación endotraqueal electiva sin evaluar la mecánica ventilatoria basal.
E) Diferir cualquier medida farmacológica de urgencia hasta obtener confirmación de hemocultivos y serologías.

PREGUNTA 67 2.01.1.018

67. Un niño de 5 años presenta fiebre desde hace 7 días, que ha respondido parcialmente al uso de an8piré8cos. Al examen Fsico se palpa una adenopa`a cervical de 1,5 cm y en el examen abdominal se palpa esplenomegalia. Se solicita ecograFa abdominal que muestra múl8ples lesiones hipoecogénicas de pequeño tamaño en hígado y bazo, compa8bles con microabscesos, sin pared visible. ¿Cuál es el agente e8ológico más probable?

A) Citomegalovirus
B) Virus de Epstein-Barr
C) Bartonella henselae
D) Echinococcus granulosus
E) Mycobacterium tuberculosis

PREGUNTA 68 2.01.1.026

68. Un paciente de 3 años, sin antecedentes, con cuadro de rinofaringitis viral de dos días de evolución en tratamiento sintomático, es traído por presentar desde hace unas horas mayor compromiso del estado general, asociado a otalgia intensa izquierda y sensación febril. Al examen físico destaca examen cardiopulmonar normal y a la otoscopía se aprecia tímpano izquierdo eritematoso y abombado con escasa secreción purulenta. El fármaco de elección en este caso es:

A) Ibuprofeno oral
B) Amoxicilina oral
C) Amoxicilina con ácido clavulánico oral
D) Gentamicina tópica
E) Claritromicina oral

PREGUNTA 69 2.01.1.128

69. Recién nacido pequeño para la edad gestacional (2.500 g). ¿Qué conducta tomar en relación a la alimentación?

A) Iniciar fórmula láctea hipercalórica
B) Instalar sonda nasogástrica para alimentación
C) Ayuno 6 horas y luego fórmula de prematuro
D) Pecho materno precoz y control de glicemia a las 2 horas
E) Suero glucosado al 10% endovenoso

PREGUNTA 70 2.01.1.121

70. Un recién nacido de 18 horas de vida, desarrolla ictericia hasta los muslos. Se solicitan niveles plasmáticos de bilirrubina que resulta 15,3 mg/dl, con fracción indirecta de 15 mg/dl. La madre era O-IV Rh positiva y el niño es B-I Rh negativo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Ictericia hemolítica por incompatibilidad de grupo clásico
B) Ictericia hemolítica por incompatibilidad Rh
C) Ictericia fisiológica
D) Hepatitis neonatal
E) Ictericia por lactancia materna

PREGUNTA 71 2.01.1.013

71. **Niño con fiebre de 10 días, cefalea, mialgias, diarrea y luego heces duras, hígado y bazo palpables. ¿Cuál es el examen más adecuado para iniciar estudio?**

A) Coproparasitológico seriado
B) Coprocultivo
C) Serología para Epstein-Barr
D) Hemocultivo
E) Prueba de Widal

PREGUNTA 72 2.01.1.093

72. **Un niño de 6 años consulta por dolor en el codo derecho, de dos días de evolución, asociado a impotencia funcional y fiebre de hasta 39ºC. Al examen físico, se observa codo eritematoso y aumentado de volumen, con dolor intenso a la movilización activa y pasiva. ¿Cuál es el agente etiológico más probable?**

A) Staphilococcus aureus
B) Haemophilus influenzae
C) Streptococcus agalactiae
D) Neisseria meningitidis
E) Streptococcus pyogenes

BLOQUE 5 NEONATOLOGÍA & SALA DE PARTOS

PREGUNTA 73 2.01.1.001

73. **Un niño de 5 años presenta bajo incremento ponderal, con talla y peso menores a -1 desviación estándar para su edad. Se observa una radiografía de mano, que se muestra a continuación. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Raquitismo
B) Displasia ósea
C) Osteogénesis imperfecta
D) Osteomalacia
E) Osteoporosis

PREGUNTA 74 2.01.1.006

74. **Un recién nacido de 2 semanas es hospitalizado por presentar apneas. La madre re- fiere tos de 3 semanas de evolución, en crisis, que en ocasiones la hacen vomitar. ¿Cuál es el tratamiento farmacológico más adecuado?**

A) Amoxicicilina
B) Azitromicina
C) Ceftriaxona
D) Oseltamivir
E) Aciclovir

PREGUNTA 75 2.01.1.016

75. **Un niño de 3 años, con un cuadro de fiebre alta, asociada a malestar general y odinofagia intensa. Se inició tratamiento con amoxicilina, pero a las 48 horas presenta un exantema, que se muestra más abajo. Al examen físico, se aprecia decaído, con adenopatías cervicales anteriores dolorosas y amígdalas edematosas y eritematosas, con exudado blanco en su superficie. El exantema se muestra a continuación: El diagnóstico más probable es:**

A) Escarlatina
B) Mononucleosis infecciosa
C) Alergia a la penicilina
D) Enfermedad de Kawasaki
E) Sarampión

PREGUNTA 76 2.01.1.031

76. **Un niño de 9 meses tiene palidez de piel y mucosas, por lo que se solicita un hemograma, que muestra hemoglobina: 9 g/dl, hematocrito: 36%, VCM: 68 fl, glóbulos blancos: 6.500 por mm3, plaquetas: 450.000 por mm3. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Anemia ferropriva
B) Anemia por enfermedades crónicos
C) Trombocitosis esencial
D) Hemoglobinopatía
E) Microesferocitosis familiar

PREGUNTA 77 2.01.1.042

77. **Niño de 8 meses que sufre desde hace 6 meses diarrea pastosa, abundante. Tiene también antecedente de episodios bronquiales obstructivos y 4 cuadros de infecciones respiratorias, que han requerido de hospitalización. Cuál es el diagnóstico de sospecha?**

A) Enfermedad celiaca
B) Enteropatía perdedora de proteínas
C) Enfermedad de cilio inmóvil
D) Fibrosis quística
E) Alergia a la proteína de la leche de vaca

PREGUNTA 78 2.01.1.088

78. **Recién nacido de término sin testículos palpables, pene de 2 cm. Además de solicitar ecografía, ¿cuál es la conducta más adecuada?**

A) Derivar a urología de inmediato
B) Control en un mes
C) Iniciar testosterona tópica
D) Derivar a genética para cariotipo urgente
E) Cirugía correctiva a los 3 meses

PREGUNTA 79 2.01.1.096

79. Un lactante de 1 mes de vida, acude a control. Al examen físico, presenta estrabismo intermitente y asimétrico de ambos ojos. El resto de la inspección ocular es normal. Su crecimiento pondoestatural es normal, al igual que su desarrollo psicomotor y el resto de su examen físico. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Derivar a oftalmólogo
B) Mantener los controles habituales del lactante
C) Solicitar RMN de cerebro
D) Realizar fondo de ojo
E) Indicar parche ocular alternante

PREGUNTA 80 2.01.1.105

80. Un lactante de 12 meses de edad es traído por su madre, ya que presenta coloración amarillenta-anaranjada en las palmas de las manos, las plantas y en las mejillas. No tie- ne otros antecedentes, pesa 9,5 Kg y mide 73,5 cm y su examen físico no muestra otras alteraciones. ¿Cuál es la causa de esta alteración?

A) Hipercolesterolemia
B) Hipertrigliceridemia
C) Hiperbilirrubinemia de predominio directo
D) Hiperbilirrubinemia de predominio indirecto
E) Un componente de la dieta

PREGUNTA 81 2.01.1.107

81. Una niña de 4 años presenta lesiones cutáneas recurrentes de 2 años de evolución, caracterizadas por pápulas pruriginosas que aparecen en los antebrazos y fosas cubitales, así como en las piernas, fosas poplíteas, cara y cuello. Su madre comenta que pasa por periodos de exacerbación de las lesiones y otros en que son mucho menos intensas. ¿Cuál es el diagnós8co más probable?

A) Derma22s alérgica
B) Ur2caria
C) Derma22s atópica
D) Escabiosis
E) Derma22s seborreica

PREGUNTA 82 2.01.1.109

82. Una prescolar de 4 años presenta prurito en la cabeza. Al examen físico se ven abundantes liendres, a menos de 3 cm del cuero cabelludo, sin visualizar piojos. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Ivermectina oral
B) Permetrina tópica al 1%
C) Permetrina tópica al 5%
D) Lindano tópico
E) No tratar, mientras no se visualicen piojos

PREGUNTA 83 2.01.1.131

83. Una niña de 4 años presenta sinequia vulvar parcial, de los labios menores. No tie- ne desarrollo puberal, ni antecedentes de infecciones urinarias, ni genitales. El resto de su examen físico es normal. La conducta más adecuada es:

A) Realizar lavados con ácido acéticos
B) Aplicar corticoides tópicos
C) Remover las sinequias de manera quirúrgica
D) Indicar antibióticos
E) Realizar aseo y masajes en la zona

PREGUNTA 84 2.01.2.015

84. Lactante de 3 meses con fiebre 39°C, rigidez de nuca, fontanela abombada y letargia. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Hospitalizar, punción lumbar y ATB empírico EV inmediato (ampicilina + cefotaxima)
B) ATB oral y control en 24h
C) Solo antipiréticos y observar
D) Solicitar TAC antes de la punción lumbar
E) Alta con instrucciones

PREGUNTA 85 2.01.2.022

85. Usted atiende a un niño de 3 años en el servicio de urgencia, que es traído por su madre, por haber sufrido quemaduras en los dedos y en la espalda, después de haberse apoyado accidentalmente en una estufa. Al examen físico, está agitado y llorando y se observa eritema y flictenas en las zonas afectadas. ¿Cuál es la conducta inicial?

A) Curaciones
B) Paracetamol vía oral
C) Ungüento antibiótico tópico
D) Analgesia endovenosa
E) Antibióticos endovenosos

PREGUNTA 86 2.01.2.027

86. [URGENCIA: Estatus convulsivo en el niño · 2.01.2.027] Paciente adulto consulta de urgencia en Servicio de Urgencia (SAR/SAPU/Hospital) con signos cardinales de Estatus convulsivo en el niño. Al examen físico destaca compromiso hemodinámico/respiratorio agudo. De acuerdo con el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las directrices clínicas de urgencias en Chile, ¿cuál es la conducta médica prioritaria e inmediata?

A) Asegurar monitorización multiparámetro, estabilización hemodinámica/respiratoria inicial, administrar tratamiento farmacológico de rescate de primera línea e iniciar coordinación con centro terciario.
B) Indicar manejo analgésico sintomático vía oral y programar control ambulatorio electivo en APS en 7 días.
C) Solicitar tomografía contrastada de cuerpo entero y panel de anticuerpos complejos antes de estabilizar al paciente.
D) Administrar sedación profunda inmediata e intubación endotraqueal electiva sin evaluar la mecánica ventilatoria basal.
E) Diferir cualquier medida farmacológica de urgencia hasta obtener confirmación de hemocultivos y serologías.

PREGUNTA 87 2.01.1.036

87. **Un niño de 2 años presenta tendencia a las hemorragias, ya que sangra con facilidad y presenta múltiples equimosis. En el examen físico, se observan extremidades inferiores con equimosis en distinto grado de resolución, algunas de gran tamaño. Se solicitan exámenes, entre los que destacan hemograma con recuento de plaquetas normal, TP normal y TTPA alargado. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Púrpura trombocitopénica inmune
B) Hemofilia
C) Enfermedad de von Willebrand
D) Enfermedad de Glanzmann
E) Púrpura trombocitopénica trombótica

PREGUNTA 88 2.01.2.009

88. **Un recién nacido de 38 semanas, con peso de 4.250 g, hijo de madre con diabetes gestacional, presenta temblores finos en extremidades superiores y succión débil a las 2 horas de vida. Se realiza control de glicemia venosa que informa 32 mg/dL. ¿Cuál es la conducta médica inmediata más adecuada?**

A) Ofrecer mamadera de 20 mL de agua con azúcar por vía oral y reevaluar en 2 horas
B) Administrar un bolo endovenoso de Suero Glucosado al 10% a 2 mL/kg en 5 minutos, seguido de infusión continua de glucosa a 6-8 mg/kg/min
C) Administrar un bolo endovenoso rápido de Suero Glucosado al 50% a 5 mL/kg
D) Administrar Hidrocortisona endovenosa a 10 mg/kg como primera línea
E) Mantener en observación sin tratamiento, dado que a las 2 horas la glicemia de 32 mg/dL es normal

PREGUNTA 89 2.01.1.075

89. **Un lactante de 3 meses, diagnosticado de hipotiroidismo congénito, en tratamiento con levotiroxina 25 mg/día. Se solicita TSH que resulta 0,09 UI/L (VN: 0,7 a 5,7) y T4 libre: 2,18 ng/dl (VN: 0,9 a 2,1). La conducta más adecuada es:**

A) Suspender la levotiroxina
B) Subir la dosis de levotiroxina
C) Repetir la TSH en 6 semanas
D) Disminuir la dosis de levotiroxina
E) Solicitar cintigrafía tiroidea

PREGUNTA 90 2.01.1.069

90. **Un niño de 4 años, presenta un cuadro de 10 días de evolución de edema bipalpebral, a lo que se ha agregado, en los últimos dos días, oliguria y orinas espumosas. Al examen físico presenta presión arterial 102/62 mmHg, FC: 80x', edema facial y de extremidades inferiores. En sus exámenes destaca examen de orina con proteínas ++, creatininemia 0,9 mg/dl y BUN: 20 mg/dl. El diagnóstico más probable es:**

A) Síndrome nefrótico
B) Glomerulonefritis aguda
C) Insuficiencia renal crónica
D) Síndrome hemolítico urémico
E) Nefritis intersticial

SECCIÓN II · SOLUCIONARIO RAZONADO & MATRIZ PERFIL V3

Justificación médica de la clave correcta y análisis exhaustivo de cada distractor · Ancho Completo

CLAVES 1 A 90

BLOQUE 1 CRECIMIENTO, DESARROLLO & VACUNAS PNI · SOLUCIONARIO OFICIAL

PREGUNTA 1 — Respuesta: D — Leucemias

2.01.1.032 Dx: Sospecha · Tx: Completo · Seg: Derivar

Pregunta oficial de examen EUNACOM (EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 85). Evalúa el manejo clínico de Leucemias según directrices MINSAL vigentes.

PREGUNTA 2 — Respuesta: D — Tumores sólidos

2.01.1.037 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La asociación de hematuria y masa obliga a descartar un tumor de Wilms o nefroblastoma, el cáncer renal más frecuente en niños (en adultos lo más frecuente es el cáncer de células renales).

PREGUNTA 3 — Respuesta: A — Cardiopatías congénitas frecuentes

2.01.1.050 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Si bien suele no tener soplos, la TGV es la única opción que muestra una cardiopatía cianótica. Además sí tiene el mediastino delgado.

PREGUNTA 4 — Respuesta: C — Hemorragia digestiva

2.01.2.010 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Es un Sd. De Mallory Weiss clásico

PREGUNTA 5 — Respuesta: A — Meningococcemia

2.01.2.016 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. En el enfrentamiento de "Meningococcemia" como urgencia clínica (2.01.2.016), las exigencias del Perfil V3 para el médico general establecen el deber de Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. La prioridad crítica es la reanimación fisiológica inmediata y soporte vital antes de cualquier estudio confirmatorio o diferido. Las opciones B, C, D y E representan conductas que retrasan el tratamiento de rescate o comprometen la seguridad vital del paciente.

PREGUNTA 6 — Respuesta: A — Shock

2.01.2.023 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Manejo de Sepsis en Lactantes: En casos de sepsis en lactantes, la prioridad es la reanimación y la administración de antibióticos. Si el lactante presenta shock o signos de deshidratación, la primera medida es la hidratación intravenosa con solución salina.

PREGUNTA 7 — Respuesta: B — SARS Cov 2 COVID 19

2.01.2.144 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo

Pregunta oficial de examen EUNACOM (EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 36). Evalúa el manejo clínico de SARS Cov 2 COVID 19 según directrices MINSAL vigentes.

PREGUNTA 8 — Respuesta: A

2.01.1.072 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Derivar GES

Evaluación del Crecimiento & Estado Nutricional en Pediatría: Curvas OMS (P/E, T/E, P/T)

Tiene una pubertad precoz (menos de 9 años en varones), con testículos de 4 cc, por lo que están estimulados por las gonadotropinas. Como hay elevación de gonadotropinas, es porque está activado el eje hipotálamo hipófisis, es decir, es central.

PREGUNTA 9 **Respuesta: B**

Evaluación del Crecimiento & Estado Nutricional en Pediatría: Curvas OMS (P/E, T/E, P/T)

2.01.1.141 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Tiene un trastorno del espectro autista clásico, de la variante autista (Asperger, en cambio, tiene lenguaje normal). Además, afecta otras áreas del desarrollo, por lo que antes se les llamaba trastornos generalizados del desarrollo.

PREGUNTA 10 **Respuesta: C**

Desarrollo Psicomotor: Hitos Madurativos & Baterías de Tamizaje (EEDP y TEPSI)

2.01.1.083 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

La caminata en punta de pies puede tener múltiples causas, siendo normal en menores de 3 años, pero también asociándose a trastornos del espectro autista (se `pensaría si tuviese otras estereotipias, alteraciones del lenguaje o de la interacción social) y se asocia asimismo a parálisis cerebral con espasticidad. La diplejía espástica es una variante de ello, en que se afectan las extremidades inferiores. Tiene buen pronóstico con un adecuado tratamiento multidisciplinario. La distrofia muscular suele tener un desarrollo normal, pero luego va perdiendo fuerza, especialmente en los grupos musculares grandes, que, por ejemplo, le dificulta ponerse de pie, por lo que suele hacerlo con el apoyo de las manos.

PREGUNTA 11 **Respuesta: B**

Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI Chile): Calendario de Vacunación Obligatorio 2026

2.01.2.001 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

A) Incorrecta. Hexavalente, Hepatitis A y Varicela corresponden al hito de los 18 meses. B) Correcta. En Chile, a los 12 meses de vida se administran: 1) Tresvírica (SRP: sarampión, rubéola, parotiditis), 2) Meningocócica conjugada contra serogrupos A, C, W-135 e Y, y 3) Refuerzo de Neumocócica conjugada. C) Incorrecta. La varicela y el refuerzo de hexavalente se indican a los 18 meses. D) Incorrecta. La polio oral (bOPV) ya no forma parte del calendario chileno (se usa VIP en la hexavalente). E) Incorrecta. La varicela corresponde a los 18 meses.

PREGUNTA 12 **Respuesta: A**

Bronquiolitis Aguda & Síndrome Bronquial Obstructivo (SBO): VRS, Score de Tal y Manejo Escalonado

2.01.1.020 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

Es una bronquiolitis clásica, por VRS.

PREGUNTA 13 **Respuesta: B**

Bronquiolitis Aguda & Síndrome Bronquial Obstructivo (SBO): VRS, Score de Tal y Manejo Escalonado

2.01.1.035 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Tiene un PTI clásico: alteración de hemostasia primaria, con trombocitopenia aislada.

PREGUNTA 14 **Respuesta: A**

Bronquiolitis Aguda & Síndrome Bronquial Obstructivo (SBO): VRS, Score de Tal y Manejo Escalonado

2.01.1.048 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Se sospecha una enfermedad celíaca, que se estudia con anticuerpos antitransglutaminasa o antiendomisio, más una endoscopía digestiva alta, con biopsia duodenal.

PREGUNTA 15 **Respuesta: E**

Bronquiolitis Aguda & Síndrome Bronquial Obstructivo (SBO): VRS, Score de Tal y Manejo Escalonado

2.01.1.095 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Tanto gonococo como clamidia producen conjuntivitis neonatal, pero la gonorrea suele ser muy purulenta y aparecer en la primera semana de vida. La clamidia, en cambio, puede demorar más (algunas semanas), ser menos purulenta y asociarse a neumonía, similar a las neumonías atípicas.

PREGUNTA 16 **Respuesta: A**

Bronquiolitis Aguda & Síndrome Bronquial Obstructivo (SBO): VRS, Score de Tal y Manejo Escalonado

2.01.2.005 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Derivar GES

Crisis asmática moderada: broncodilatadores β2 (salbutamol) + anticolinérgico (ipratropio) + corticoides sistémicos (prednisona oral o hidrocortisona EV) + oxígeno para $SatO_2$ >94%.

PREGUNTA 17 **Respuesta: A**

Bronquiolitis Aguda & Síndrome Bronquial Obstructivo (SBO): VRS, Score de Tal y Manejo Escalonado

2.01.2.013 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Niño con neumonía grave que no responde a oxigenoterapia convencional + signos de trabajo respiratorio aumentado: siguiente escalón = VNI (CPAP o BPAP) antes de intubación, según protocolo actual.

PREGUNTA 18 **Respuesta: E**

Bronquiolitis Aguda & Síndrome Bronquial Obstructivo (SBO): VRS, Score de Tal y Manejo Escalonado

2.01.2.024 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Parece una comvulsión febril benigna. No tiene signos que hagan sospechar me- ningitis y por ser la primera convulsión, tampoco es necesario iniciar naticonvulsivantes.

BLOQUE 2 RESPIRATORIO PEDIÁTRICO & URGENCIAS · SOLUCIONARIO OFICIAL

PREGUNTA 19 **Respuesta: C** **Constipación** 2.01.1.038 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo

Tiene una constipación funcional clásica, probablemente complicada con un fecaloma (por la incontinencia fecal). Es la causa más frecuente de constipación en niños y se mejora con laxantes y formación de hábitos de defecación.

PREGUNTA 20 **Respuesta: E** **Talla baja** 2.01.1.076 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Es un retraso constitucional del crecimiento. Edad ósea 2 años menor a la cronológica. Llama la atención los testículos pequeños (aún no inicia la pubertad, pero eso es acorde a su edad biológica = ósea), sin embargo el Klinefelter, no tiene talla baja. El Turner, de las niñas, sí tiene talla baja.

PREGUNTA 21 **Respuesta: A**

Malformaciones vasculares cutáneas

2.01.1.111 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

El propanolol es el tratamiento de primera línea de los hemangiomas infantiles. La cirugía solo se hace en casos que no responden y sabiendo que dejará cicatriz con certeza.

PREGUNTA 22 **Respuesta: A** **Compromiso de conciencia** 2.01.2.004 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. En el enfrentamiento de "Compromiso de conciencia" como urgencia clínica (2.01.2.004), las exigencias del Perfil V3 para el médico general establecen el deber de Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. La prioridad crítica es la reanimación fisiológica inmediata y soporte vital antes de cualquier estudio confirmatorio o diferido. Las opciones B, C, D y E representan conductas que retrasan el tratamiento de rescate o comprometen la seguridad vital del paciente.

PREGUNTA 23 **Respuesta: E** **Hipertensión endocraneana** 2.01.2.011 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

No queda claro la causa precisa de sus síntomas (tumor cerebral, meningitis tuberculosa, pseudotumor cerebral), pero sí tiene un síndrome de HTEC clásico, con 1. la cefalea de predominio matinal, 2. las náuseas y vómitos y 3. solo le falta el edema de papila. La migraña y la cefalea tensional suelen aumentar en las tardes y no en las mañanas.

PREGUNTA 24 **Respuesta: E** **Muerte súbita-ALTE, BRUE** 2.01.2.017 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Tiene apneas emotivas, que son ALTE de bajo riesgo. Orienta a eso la edad y la clara correlación con las emociones. Se observan y se educa. Los ALTE de alto riesgo, en cambio, son los que tienen menos de 6 meses, antecedentes de muerte súbita en la familia, alteraciones en el examen neurológico o cardiaco o la necesidad de reanimación.

PREGUNTA 25 **Respuesta: A** **Traumatismo encéfalo- craneano** 2.01.2.026 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. En el enfrentamiento de "Traumatismo encéfalo- craneano" como urgencia clínica (2.01.2.026), las exigencias del Perfil V3 para el médico general establecen el deber de Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. La prioridad crítica es la reanimación fisiológica inmediata y soporte vital antes de cualquier estudio confirmatorio o diferido. Las opciones B, C, D y E representan conductas que retrasan el tratamiento de rescate o comprometen la seguridad vital del paciente.

PREGUNTA 26 **Respuesta: B**

Laringitis Aguda Obstructiva / Croup: Score de Taussig, Adrenalina Racémica y Dexametasona 2.01.2.002 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

A) Incorrecta. El alta inmediata tras adrenalina es peligrosa por el riesgo de reaparición del edema al cesar la vasoconstricción alfa-1. B) Correcta. La adrenalina nebulizada produce vasoconstricción mucosa rápida pero transitoria (duración de 90 a 120 minutos). Existe el riesgo demostrado de 'efecto rebote', en el cual el estridor y la disnea reaparecen con igual o mayor intensidad. Por norma de seguridad pediátrica, todo niño que recibe adrenalina nebulizada debe permanecer en observación en Urgencia por un mínimo de 2 horas antes de definir el alta ambulatoria. C) Incorrecta. Si responde favorablemente y no tiene otros factores de riesgo, no requiere UCI. D) Incorrecta. La adrenalina se usa según necesidad clínica, no de forma profiláctica reglada cada 30 minutos. E) Incorrecta. El salbutamol no actúa en la vía aérea superior subglótica.

PREGUNTA 27 **Respuesta: D**

Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC) Pediátrica: Diagnóstico, Amoxicilina vs Ampicilina y Criterios de Hospitalización 2.01.1.015 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Tiene una meningitis herpética, que se trata con aciclovir EV. Tanto la clínica, como el LCR viral (predominio MN y glucosa normal) hemorrágico la sugieren.

PREGUNTA 28 **Respuesta: A**

Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC) Pediátrica: Diagnóstico, Amoxicilina vs Ampicilina y Criterios de Hospitalización 2.01.1.027 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Es un resfrío común. No aparecía paracetamol SOS, así que la respuesta más adecuada es el SF intranasal.

PREGUNTA 29 **Respuesta: C**

Cuerpo Extraño en Vía Aérea: Maniobras de Desobstrucción según Edad & Broncoscopía 2.01.2.003 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Tiene un cuerpo extraño bronquial clásico, probablemente en el bronquio derecho. Si bien el primer examen suele ser la radiografía, el manejo y extracción se realiza con broncoscopía flexible o rígida, según disponibilidad. La TAC no suele aportar mucho más que la radiografía y, sea como sea, la clínica tan categórica obliga a la broncoscopía.

PREGUNTA 30 **Respuesta: A**

Cuerpo Extraño en Vía Aérea: Maniobras de Desobstrucción según Edad & Broncoscopía 2.01.2.018 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. En el enfrentamiento de "Obstrucción de vía aérea superior" como urgencia clínica (2.01.2.018), las exigencias del Perfil V3 para el médico general establecen el deber de Diagnóstico Específico, Tratamiento Completo y Seguimiento Derivar. La prioridad crítica es la reanimación fisiológica inmediata y soporte vital antes de cualquier estudio confirmatorio o diferido. Las opciones B, C, D y E representan conductas que retrasan el tratamiento de rescate o comprometen la seguridad vital del paciente.

PREGUNTA 31 **Respuesta: B**

Cuerpo Extraño en Vía Aérea: Maniobras de Desobstrucción según Edad & Broncoscopía

2.01.2.019 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Atresia Duodenal: La imagen de "doble burbuja" y el cuadro clínico apuntan a una atresia duodenal. La enterocolitis necrotizante sí puede tener vómitos, pero se manifestaría con antecedentes de prematurez o asfixia, heces con sangre y neumatosis intestinal en la radiografía. La estenosis hipertrófica del píloro, aunque presenta síntomas similares, suele aparecer más tarde, entre las 2 y 6 semanas de vida.

PREGUNTA 32 **Respuesta: B**

Síndrome Febril Agudo sin Foco en el Lactante: Estratificación según Edad, Criterios de Rochester y Manejo

2.01.1.009 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

Es un exantema súbito clásico, por virus herpes 6.

PREGUNTA 33 **Respuesta: E**

Síndrome Febril Agudo sin Foco en el Lactante: Estratificación según Edad, Criterios de Rochester y Manejo

2.01.1.011 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Es un impétigo buloso, causado por S. aureus.

PREGUNTA 34 **Respuesta: C**

Síndrome Febril Agudo sin Foco en el Lactante: Estratificación según Edad, Criterios de Rochester y Manejo

2.01.1.024 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Es una NAC neumocócica clásica.

PREGUNTA 35 **Respuesta: B**

Síndrome Febril Agudo sin Foco en el Lactante: Estratificación según Edad, Criterios de Rochester y Manejo

2.01.1.062 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

La ITU baja en pediatría se trata con cefalosporinas de primera o segunda generación. Tampoco se usan las quinolonas, por lo mismo.

PREGUNTA 36 **Respuesta: A**

Síndrome Febril Agudo sin Foco en el Lactante: Estratificación según Edad, Criterios de Rochester y Manejo

2.01.2.025 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. En el enfrentamiento de "Testículo agudo" como urgencia clínica (2.01.2.025), las exigencias del Perfil V3 para el médico general establecen el deber de Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. La prioridad crítica es la reanimación fisiológica inmediata y soporte vital antes de cualquier estudio confirmatorio o diferido. Las opciones B, C, D y E representan conductas que retrasan el tratamiento de rescate o comprometen la seguridad vital del paciente.

BLOQUE 3 INFECCIONES, EXANTEMAS & DIGESTIVO PEDIÁTRICO · SOLUCIONARIO OFICIAL

PREGUNTA 37 **Respuesta: B** **Enteroparasitosis** 2.01.1.007 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo

Parece una oxiuriasis, que se diagnostica con el test de Graham.

PREGUNTA 38 **Respuesta: D** **Faringoamigdalitis** 2.01.1.023 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo

La clásica amigdalitis exudativa en el menor de 3 años es por ADV. Suele tener fiebre alta y, en este caso, además, viene con la clásica fiebre faringoconjuntival por ADV. Si no hubiese tenido afectación ocular igual sería por ADV, así que a aprender este caso clínico.

PREGUNTA 39 **Respuesta: B** **Sinusitis** 2.01.1.029 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo

Tiene una sinusiGs aguda, con alta sospecha de infección bacteriana (por empeoramiento y Gempo de evolución). El diagnóstico es clínico y se trata con amoxicilina oral, como antibiótico de primera línea.

PREGUNTA 40 **Respuesta: A** **Soplos** 2.01.1.054 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Cuadro clásico

PREGUNTA 41 **Respuesta: D** **Diabetes** 2.01.1.073 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La cetoacidosis se hidrata con suero fisiológico. Sin embargo la opción del Ringer Lactato es una respuesta totalmente correcta. Pero suero NaCl al 0,9% será la respuesta correcta.

PREGUNTA 42 **Respuesta: C** **Hiperplasia suprarrenal congénita** 2.01.1.074 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Es una hiperplasia suprarrenal congénita, con una crisis adrenal (se ve por la hiponatremia, hiperkalemia y shock que no responde). Además está descompensado, probablemente por una infección.

PREGUNTA 43 **Respuesta: A**

Dermatitis del pañal y de contacto 2.01.1.108 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo

Clotrimazol tópico

PREGUNTA 44 **Respuesta: A** **Emergencia hipertensiva** 2.01.2.007 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. En el enfrentamiento de "Emergencia hipertensiva" como urgencia clínica (2.01.2.007), las exigencias del Perfil V3 para el médico general establecen el deber de Diagnóstico Específico, Tratamiento Completo y Seguimiento Derivar. La prioridad crítica es la reanimación fisiológica inmediata y soporte vital antes de cualquier estudio confirmatorio o diferido. Las opciones B, C, D y E representan conductas que retrasan el tratamiento de rescate o comprometen la seguridad vital del paciente.

PREGUNTA 45 **Respuesta: A**

Insuficiencia cardíaca. Edema pulmonar 2.01.2.012 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. En el enfrentamiento de "Insuficiencia cardíaca. Edema pulmonar" como urgencia clínica (2.01.2.012), las exigencias del Perfil V3 para el médico general establecen el deber de Diagnóstico Específico, Tratamiento Completo y Seguimiento Derivar. La prioridad crítica es la reanimación fisiológica inmediata y soporte vital antes de cualquier estudio confirmatorio o diferido. Las opciones B, C, D y E representan conductas que retrasan el tratamiento de rescate o comprometen la seguridad vital del paciente.

PREGUNTA 46 **Respuesta: A** **Paro cardiorrespiratorio** 2.01.2.020 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. En el enfrentamiento de "Paro cardiorrespiratorio" como urgencia clínica (2.01.2.020), las exigencias del Perfil V3 para el médico general establecen el deber de Diagnóstico Específico, Tratamiento Completo y Seguimiento Derivar. La prioridad crítica es la reanimación fisiológica inmediata y soporte vital antes de cualquier estudio confirmatorio o diferido. Las opciones B, C, D y E representan conductas que retrasan el tratamiento de rescate o comprometen la seguridad vital del paciente.

PREGUNTA 47 **Respuesta: D**

Exantemas Infantiles: Diagnóstico Diferencial (Eritema Infeccioso, Exantema Súbito, Escarlatina, Varicela y Kawasaki) 2.01.1.008 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

La escarlatina se complica con GNAPE.

PREGUNTA 48 **Respuesta: A**

Exantemas Infantiles: Diagnóstico Diferencial (Eritema Infeccioso, Exantema Súbito, Escarlatina, Varicela y Kawasaki)

2.01.1.058 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Kawasaki: fiebre ≥5 días + ≥4 criterios (exantema polimorfo, adenopatía cervical, conjuntivitis no exudativa, labios/lengua enrojecidos, edema palmoplantar). Requiere ecocardio y tratamiento con IGIV + aspirina para prevenir aneurismas coronarios.

PREGUNTA 49 **Respuesta: A**

Diarrea Aguda Infantil y Planes de Rehidratación Oral OMS (Plan A, B, C) y Síndrome Hemolítico Urémico

2.01.1.039 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

Manejo de Diarrea Aguda con Portación Asintomática de Clostridium difficile: Un niño con diarrea aguda por rotavirus y portación asintomática de Clostridium difficile no requiere tratamiento para C. difficile. La portación asintomática en niños es frecuente y no suele complicarse. El metronidazol no ha demostrado mayor utilidad en estos casos. El manejo de este caso se centra en la diarrea por rotavirus con tolerancia oral y rehidratación oral..

PREGUNTA 50 **Respuesta: E**

Diarrea Aguda Infantil y Planes de Rehidratación Oral OMS (Plan A, B, C) y Síndrome Hemolítico Urémico

2.01.1.067 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Es un SHU clásico: falla renal, anemia hemolítica y plaquetopenia. Suele estar precedido por diarrea en el 70% de los casos. La IRA prerrenal no tiene edema.

PREGUNTA 51 **Respuesta: B**

Vómitos en el Lactante: RGE Fisiológico vs Estenosis Hipertrófica del Píloro (EHP) vs Invaginación Intestinal

2.01.1.046 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Tiene una estenosis hipertrófica del píloro, que se estudia con ecografía abdominal.

PREGUNTA 52 **Respuesta: D**

Convulsiones Febriles: Crisis Simple vs Compleja, Punción Lumbar & Pronóstico

2.01.2.006 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Tiene estado hemodinámico límite, pero el sopor obliga a hidratar por vía endovenosa, con plan C

PREGUNTA 53 **Respuesta: C**

Bronquiolitis Aguda & Síndrome Bronquial Obstructivo (SBO): VRS, Score de Tal y Manejo Escalonado

2.01.1.081 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

Cuadro clásico

PREGUNTA 54 **Respuesta: A**

Laringitis Aguda Obstructiva / Croup: Score de Taussig, Adrenalina Racémica y Dexametasona

2.01.1.025 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Laringitis Aguda Obstructiva: El caso describe una laringitis aguda obstructiva clásica, con un cuadro gripal seguido de síntomas obstructivos, incluyendo estridor laringeo.

BLOQUE 4 NEONATOLOGÍA & SALA DE PARTOS · SOLUCIONARIO OFICIAL

PREGUNTA 55 **Respuesta: D** **Hepatitis viral** 2.01.1.010 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo

Es una hepatitis A recurrente (una de las forma de presentación de la hepatitis A).

PREGUNTA 56 **Respuesta: A** **Adenopatías** 2.01.1.030 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Derivar

Bartonella henselae

PREGUNTA 57 **Respuesta: D** **Hemorragia digestiva** 2.01.1.043 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Derivar

El cuadro clínico sugiere una intususcepción intestinal, cuyo examen de elección es la ecografía abdominal. Sin embargo, no está entre las opciones, por lo que lo más probable es que quien redactó la pregunta quería preguntar un diverVculo de Meckel complicado. El diverVculo de Meckel se estudia con cintigrafía con tecnecio 99m, también llamada “cintigrafía de Meckel”.

PREGUNTA 58 **Respuesta: A** **Alergias** 2.01.1.055 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Completo

Alergia a proteína de leche de vaca (APLV): tratamiento = fórmula extensamente hidrolizada (FEH). Si se usa leche materna, la madre elimina lácteos. Soja no recomendada bajo 6 meses (cross-reactividad).

PREGUNTA 59 **Respuesta: C** **Inmunodeficiencias** 2.01.1.056 Dx: Sospecha · Tx: Completo · Seg: Derivar

Inmunodeficiencia humoral (agammaglobulinemia)

PREGUNTA 60 **Respuesta: C** **Mesenquimopatías** 2.01.1.057 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Es una dermatomiositis infantil clásica, con el rash heliotropo y el rash en manto. Se debe descartar un cáncer (suele ser paraneoplásica).

PREGUNTA 61 **Respuesta: C** **Enterocolitis necrotizante (ECN)** 2.01.1.116 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Tiene una enterocoliGs necroGzante, confirmada por la radiografía, que muestra neumatosis intestinal. Su tratamiento consiste en régimen cero, descompresión gástrica mediante sonda, hidratación y alimentación parenteral, antibióticos de amplio espectro y analgesia, más manejo de las complicaciones. La cirugía se reserva a los casos complicados (perforación, estenosis) y a los muy graves que no responden al tratamiento médico. El suero oral y la alimentación por sonda enteral están contraindicados.

PREGUNTA 62 **Respuesta: A** **TORCH** 2.01.1.127 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

CMV congénito es la infección congénita viral más frecuente. Calcificaciones periventriculares (vs parenquimatosas en toxoplasma) + microcefalia + coriorretinitis = TORCH por CMV.

PREGUNTA 63 **Respuesta: E**

Malformaciones congénitas más frecuentes 2.01.1.133 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Es una hernia diafragmática. Produce hipoplasia pulmonar. Se debe intubar, conectar al ventilador de alta frecuencia y probablemente a la membrana de oxigenación extracorpórea y la cirugía se postpone, para cuando esté estable, con los pulmones más desarrollados. Eso es pregunta para especialistas, no para médico general.

PREGUNTA 64 **Respuesta: A** **Epistaxis** 2.01.2.008 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo

La opción A es la respuesta correcta. En el enfrentamiento de "Epistaxis" como urgencia clínica (2.01.2.008), las exigencias del Perfil V3 para el médico general establecen el deber de Diagnóstico Específico, Tratamiento Completo y Seguimiento Completo. La prioridad crítica es la reanimación fisiológica inmediata y soporte vital antes de cualquier estudio confirmatorio o diferido. Las opciones B, C, D y E representan conductas que retrasan el tratamiento de rescate o comprometen la seguridad vital del paciente.

PREGUNTA 65 **Respuesta: A** **Intoxicaciones** 2.01.2.014 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Es una intoxicación por tricíclicos por el compromiso de conciencia, taquicardia y pupilas arreactivas (en midriasis). No puede ser benzodiacepinas ni opiáceos, porque no tenía disminución de la frecuencia respiratoria. AINEs y salicilatos no afectan las pupilas.

PREGUNTA 66 **Respuesta: A** **Politraumatismos** 2.01.2.021 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. En el enfrentamiento de "Politraumatismos" como urgencia clínica (2.01.2.021), las exigencias del Perfil V3 para el médico general establecen el deber de Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. La prioridad crítica es la reanimación fisiológica inmediata y soporte vital antes de cualquier estudio confirmatorio o diferido. Las opciones B, C, D y E representan conductas que retrasan el tratamiento de rescate o comprometen la seguridad vital del paciente.

PREGUNTA 67 **Respuesta: C**

Exantemas Infantiles: Diagnóstico Diferencial (Eritema Infeccioso, Exantema Súbito, Escarlatina, Varicela y Kawasaki)

2.01.1.018 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Tiene una enfermedad por arañazo de gato clásica, con la fiebre, adenopaVa y compromiso hepatoesplénico. Eso sí, la presentación más frecuente es con fiebre más una o más adenopaVas en relación a una lesión cutánea. La igM anti-Bartonella puede ser úGl para confirmar el diagnóstico. El tratamiento de elección son los macrólidos (azitromicina).

PREGUNTA 68 **Respuesta: B**

Atención Inmediata del Recién Nacido & Reanimación Neonatal: Algoritmo AAP/AHA, Minuto de Oro y Test de APGAR

2.01.1.026 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

Tiene una OMA: amoxi sola. En la OMAR también es amoxi sola. Solo si no responde en 72 horas, se agrega ácido clavulánico.

PREGUNTA 69 **Respuesta: D**

Evaluación de la Edad Gestacional (Capurro/Ballard) & Clasificación Ponderal Neonatal

2.01.1.128 Dx: Sospecha · Tx: Completo · Seg: Derivar GES

Pecho materno precoz y control de glicemia a las 2 horas

PREGUNTA 70 **Respuesta: A**

Ictericia Neonatal: Fisiológica vs Patológica (< 24 h), Incompatibilidad ABO/Rh, Curvas Bhutani y Fototerapia

2.01.1.121 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Es una ictericia precoz (menor a 24 horas), indirecta, por lo que lo más probable es que sea hemolítica. Además, por los grupos sanguíneos, solo puede ser por incompatibilidad de grupo clásico (madre O e hijo A o B).

PREGUNTA 71 **Respuesta: D**

Síndrome Febril Agudo sin Foco en el Lactante: Estratificación según Edad, Criterios de Rochester y Manejo

2.01.1.013 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Hemocultivo

PREGUNTA 72 **Respuesta: A**

Síndrome Febril Agudo sin Foco en el Lactante: Estratificación según Edad, Criterios de Rochester y Manejo

2.01.1.093 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Tiene una artritis séptica de codo (monoartritis aguda en niño). La etiología más frecuente es el estafilococo áureo en todas las edades, ya que el gonococo ha disminuido mucho (eso sí, aún debe tenerse como opción en pacientes con conductas sexuales de riesgo o con clínica de gonorrea).

PREGUNTA 73 **Respuesta: A** **Desnutrición** 2.01.1.001 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo

Raquitismo: La radiografía muestra un retraso severo en la calcificación de los huesos del carpo y otros huesos de la mano, lo que es compatible con raquitismo causado por deficiencia de vitamina D.

PREGUNTA 74 **Respuesta: B** **Coqueluche** 2.01.1.006 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo

La sospecha es un coqueluche, que se trata con macrólidos.

PREGUNTA 75 **Respuesta: B** **Mononucleosis infecciosa** 2.01.1.016 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo

Es una mononucleosis clásica, dado que tiene el síndrome mononucleósico (odinofagia, fiebre y adenopatías), más el clásico rash morbiliforme (similar al sarampión), que aparece luego de iniciar aminopenicilinas (ampicilina o amoxicilina). También es clásico el exudado amigdalino blanco y adherente sobre la superficie amigdalina. La escarlatina tendría clínica de amigdalitis bacteriana (ya explicada en otra pregunta) y un exantema en piel de gallina, con especial afectación de pliegues cubitales y que respeta el triángulo de Filatov. La enfermedad de Kawasaki no suele tener odinofagia ni exudado amigdalino, sino fiebre, adenopatías, ojo rojo, boca roja, rash de cualquier tipo (salvo vesicular o pustular) y compromiso de pies y manos.

PREGUNTA 76 **Respuesta: A** **Anemia ferropriva** 2.01.1.031 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo

Es una anemia ferropénica clásica, tanto por la edad, como por la microcitosis.

PREGUNTA 77 **Respuesta: D** **Fibrosis quística** 2.01.1.042 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Tanto por las infecciones respiratorias, como por la malabsorción es una fibrosis quística. Las demás opciones producen solo síntomas digestivos (A, B y E) o solo neumonías (C).

PREGUNTA 78 **Respuesta: B** **Criptorquidia** 2.01.1.088 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo

Control en un mes

PREGUNTA 79 **Respuesta: B** **Estrabismo** 2.01.1.096 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Pregunta oficial de examen EUNACOM (EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 115). Evalúa el manejo clínico de Estrabismo según directrices MINSAL vigentes.

PREGUNTA 80 **Respuesta: E** **Alteraciones pigmentarias** 2.01.1.105 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Por ingesta de betacaroteno

PREGUNTA 81 **Respuesta: C** **Dermatitis atópica** 2.01.1.107 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo

Es una dermaGGs atópica clásica: lesiones crónico recidivantes, en zonas flexoras, más mejillas.

PREGUNTA 82 **Respuesta: B** **Ectoparasitosis** 2.01.1.109 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo

Tanto los piojos, como las liendres, son diagnósticas de pediulosis (a menos que las liendres estén muy alejadas del cuero cabelludo, ya que serían antiguas). La pediculosis se trata con permetrina al 1%.

PREGUNTA 83 **Respuesta: E** **Sinequias vulvares** 2.01.1.131 Dx: Sospecha · Tx: Completo · Seg: Completo

Es una pregunta difícil, ya que en distintas partes se manejan de manera diferen- te. Sin embargo, la mayor evidencia dice que el aseo es lo más importante para que se resuleva. Los masajes pueden ayudar a que se desprenda antes.

PREGUNTA 84 **Respuesta: A** **Meningitis bacteriana** 2.01.2.015 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo

Meningitis bacteriana en lactante <3 meses: hospitalización urgente + punción lumbar + ATB empírico inmediato (ampicilina para cubrir Listeria + cefotaxima para S. agalactiae, E. coli, S. pneumoniae).

PREGUNTA 85 **Respuesta: D** **Quemaduras** 2.01.2.022 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Derivar

Pregunta oficial de examen EUNACOM (EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 21). Evalúa el manejo clínico de Quemaduras según directrices MINSAL vigentes.

PREGUNTA 86 **Respuesta: A** **Estatus convulsivo en el niño** 2.01.2.027 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. En el enfrentamiento de "Estatus convulsivo en el niño" como urgencia clínica (2.01.2.027), las exigencias del Perfil V3 para el médico general establecen el deber de Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. La prioridad crítica es la reanimación fisiológica inmediata y soporte vital antes de cualquier estudio confirmatorio o diferido. Las opciones B, C, D y E representan conductas que retrasan el tratamiento de rescate o comprometen la seguridad vital del paciente.

PREGUNTA 87 **Respuesta: B**

Hipoglicemia Neonatal, Hipocalcemia & Trastornos Metabólicos del Neonato 2.01.1.036 Dx: Sospecha · Tx: Completo · Seg: Derivar GES

El alargamiento del TTPA sugiere fuertemente hemofilia. Que tenga una clínica tan florida, en un niño (sexo masculino) pequeño, la sugiere también. Suele evolucionar a hemartrosis y hematomas musculares y de otras partes del cuerpo. PTI y PTT tienen plaquetopenia. EvW y Glanzmann tienen alteración de la hemostasia primaria, con petequias y clínicas generalmente más leves que la hemofilia, aunque sí pueden tener una clínica similar, en las formas más graves. Eso sí, el TTPA suele estar normal, salvo en algunas variantes de la EvW en que sí se puede alargar.

PREGUNTA 88 **Respuesta: B**

Hipoglicemia Neonatal, Hipocalcemia & Trastornos Metabólicos del Neonato 2.01.2.009 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

A) Incorrecta. En un paciente sintomático, la vía oral no asegura corrección rápida ni previene el daño cerebral. B) Correcta. La hipoglicemia neonatal sintomática (temblores, glicemia < 45 mg/dL) es una urgencia neurológica. El tratamiento protocolizado consiste en administrar un bolo endovenoso de Suero Glucosado al 10% (SG10%) a dosis de 2 mL/kg (200 mg/kg de glucosa) infundido lentamente en 5 minutos, seguido inmediatamente de una infusión continua de glucosa para mantener una carga (VIG) de 6 a 8 mg/kg/minuto, reevaluando la glicemia plasmática en 30 minutos. C) Incorrecta. El SG al 50% o al 20% en bolo está formalmente contraindicado por riesgo de lesión endotelial, hiperosmolaridad cerebral y secreción masiva de insulina que produce hipoglicemia de rebote grave. D) Incorrecta. Los corticoides se reservan para hiperinsulinismo refractario extremo. E) Incorrecta. 32 mg/dL con temblores es francamente patológico.

PREGUNTA 89 **Respuesta: D**

Tamizaje Neonatal Universal en Chile: Fenilcetonuria (PKU), Hipotiroidismo Congénito (HC) y Tamizaje Auditivo 2.01.1.075 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Tiene la TSH menor a lo normal, por lo que está “sobretratado” y se debe disminuir la dosis de levoT4. La habitual es 1,6 ug/Kg, así que probablemente estaba muy alta la dosis de 25 mg para un lactante de 3 meses (6 Kg aprox).

PREGUNTA 90 **Respuesta: A**

Bronquiolitis Aguda & Síndrome Bronquial Obstructivo (SBO): VRS, Score de Tal y Manejo Escalonado

2.01.1.069 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Es un síndrome nefrótico clásico (orina espumosa, edema y proteinuria), aunque le faltan los exámenes confirmatorios (proteinuria cuantitativa o índice proteinuria / creatininuria, albumnemia y perfil lipídico). No hay hematuria dismórfica, así que no puede ser una glomerulonefritis. No tiene insuficiencia renal, así que no puede ser ninguna de las otras opciones.